

Flashcards ENARM -- Pediatría

68 patologías · 374 tarjetas · generado 2026-09-12 por La Mole. Frente = pregunta tipo ENARM; Reverso = respuesta + dato diferencial.

Enfermedades Exantemáticas

Tarjeta 1 -- FRENTE: Lactante con fiebre alta de 3 días que cede de forma súbita y, en las siguientes 24 horas, aparece exantema maculopapular rosado en tronco, cuello y cara, sin descamación. Agente etiológico y diagnóstico.

REVERSO: Herpesvirus humano tipo 6B (HHV-6B): roséola o exantema súbito (sexta enfermedad), diagnóstico clínico. Diferencial: el eritema infeccioso inicia en mejillas con aspecto de "mejillas abofeteadas" y es por parvovirus B19.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Niña de 7 años con exantema en tres fases: mejillas "abofeteadas", luego exantema reticular en tronco y extremidades que reaparece con calor o estrés. Agente y complicación temida en pacientes con anemia hemolítica de base.

REVERSO: Parvovirus B19 (eritema infeccioso o quinta enfermedad). Complicación: crisis aplásica transitoria (reticulocitopenia); en la embarazada causa hidropesía fetal.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Frente: niño con exantema polimorfo donde coexisten máculas, pápulas, vesículas y costras en distinto estadio evolutivo. Diagnóstico y antipirético contraindicado.

REVERSO: Varicela (VZV, herpesvirus humano tipo 3). Contraindicados: ácido acetilsalicílico (síndrome de Reye), ibuprofeno (sobreinfección estreptocócica) y corticoides. Antipirético de elección: paracetamol. Diferencial: las lesiones en todos los estadios a la vez distinguen a la varicela.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Complicación tardía más frecuente de la escarlatina y su relación con la localización de la infección previa.

REVERSO: Glomerulonefritis postinfecciosa, secundaria a cepas nefritogénicas de *Streptococcus pyogenes*. La fiebre reumática ocurre solo tras infecciones faríngeas (no cutáneas); la escarlatina cursa con exantema "de lija", lengua aframbuesada y signo de Pastia.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Niño de 5 años con fiebre, tos, rinitis y conjuntivitis, puntos de Koplik en mucosa yugal y exantema maculopapular cefalocaudal que respeta palmas y plantas. Diagnóstico y medida terapéutica específica.

REVERSO: Sarampión (Paramyxoviridae). Tratamiento de soporte con vitamina A según dosis OMS. Dato diferencial: los puntos de Koplik (exantema frente a los segundos molares) aparecen antes del exantema.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Periodo de contagio del sarampión respecto a la aparición del exantema.

REVERSO: 4 días antes y 4 días después del exantema. Diferencial: la rubéola contagia 10 días antes y 7 días después, y cursa con adenopatías retroauriculares dolorosas.

Epiglotitis

Tarjeta 1 -- FRENTE: Niño con fiebre alta, sialorrea, disfagia, disfonía y disnea, sentado en posición tripódica, sin tos y con aspecto tóxico. Diagnóstico y agente etiológico clásico.

REVERSO: Epiglotitis por *Haemophilus influenzae* tipo b. Los "4 D" (drooling, disfagia, disfonía, disnea) y el tripódico sin tos la distinguen del crup, que cursa con tos perruna y evolución gradual.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Manejo inicial en un niño con epiglotitis: qué NO debe hacerse y cuál es la prioridad.

REVERSO: No sedar, no explorar la garganta con espátula y no manipular al paciente (riesgo de obstrucción total de la vía aérea). Prioridad: asegurar la vía aérea con intubación orotraqueal en quirófano con cirujano presente.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Hallazgo radiológico clásico de la epiglotitis en la radiografía lateral de cuello y su utilidad real.

REVERSO: Signo del pulgar (epiglotis engrosada). Su baja sensibilidad disminuye su utilidad; el diagnóstico definitivo es la visualización de epiglotis edematosa e hiperémica por laringoscopia directa en quirófano.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Antibiótico de elección y medida para los contactos de un caso de epiglotitis.

REVERSO: Ceftriaxona o cefotaxima IV por 7-10 días; profilaxis de contactos con rifampicina. Diferencial: el crup es viral y no requiere antibióticos ni profilaxis.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Niño de 2 años con estridor, tos perruna y voz ronca de evolución gradual, sin aspecto tóxico. Diagnóstico diferencial con la epiglotitis.

REVERSO: Laringotraqueobronquitis (crup): 6 meses a 3 años, tos traqueal (perruna), evolución más gradual y sin aspecto tóxico. La epiglotitis tiene inicio abrupto, sialorrea, disfagia y aspecto tóxico.

Epiglotitis (Pediátrica)

Tarjeta 1 -- FRENTE: Antibióticos de elección en la epiglotitis pediátrica y duración del esquema.

REVERSO: Ceftriaxona o cefotaxima por 7-10 días. Alternativas: trimetoprim-sulfametoxazol, ampicilina-sulbactam y ampicilina-cloranfenicol. Diferencial: en el crup no se indican antibióticos.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cómo se establece el diagnóstico definitivo de epiglotitis y en qué pacientes se reserva la laringoscopia directa?

REVERSO: Visualización de una epiglotis edematosa e hiperémica, idealmente bajo laringoscopia directa, reservada a casos graves y efectuada preferentemente en quirófano. En enfermedad leve-moderada se usa nasofibroscopia (contraindicada si hay inestabilidad de la vía aérea).

Tarjeta 3 -- FRENTE: Cuatro factores de riesgo para desarrollar epiglotitis en la era posvacuna Hib.

REVERSO: Carencia de inmunización contra Hib, edad de 5-11 años y sexo masculino, inmunosupresión (terapia inmunosupresora, neoplasia, inmunodeficiencia) y uso persistente de antibióticos o hipoparatiroidismo. Diferencial: en inmunocomprometidos considerar Candida, VHS-1, VVZ y parainfluenza.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Antes de asegurar la vía aérea, ¿qué maniobras se evitan en el niño con epiglotitis y por qué?

REVERSO: Venopunciones, posturas no elegidas por el paciente y separación del familiar acompañante, para evitar la agitación que precipita la obstrucción total de la vía aérea. El oxígeno se reserva para saturación <92% o dificultad respiratoria grave.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Signo radiológico descrito en epiglotitis y su limitación principal.

REVERSO: Signo del pulgar en radiografía lateral de cuello; su baja sensibilidad disminuye su utilidad diagnóstica. No retrasa ni sustituye la visualización directa y el aseguramiento de la vía aérea.

Craneofaringioma

Tarjeta 1 -- FRENTE: Origen embriológico y localización habitual del craneofaringioma.

REVERSO: Tumor benigno surgido de remanentes de la bolsa de Rathke, usualmente supraselar y parcialmente calcificado (sólido o mixto con componente quístico). Diferencial: el adenoma de hipófisis es intraselar y produce hemianopsia bitemporal por compresión central del quiasma.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Forma de presentación típica del craneofaringioma en niños.

REVERSO: Cefalea y alteraciones visuales, además de trastornos del crecimiento (por hipopituitarismo). Diferencial: en adultos predomina el hipopituitarismo y en la adenoma de hipófisis la cuadrantanopsia bitemporal superior.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Distribución por edad del craneofaringioma.

REVERSO: Bimodal: predominantemente en niños, con un discreto aumento de incidencia entre los 55-65 años. Diferencial: el craneofaringioma pese a incluirse en secciones de tumores malignos pediátricos es histológicamente benigno.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Tratamiento del craneofaringioma.

REVERSO: Cirugía, radioterapia o la combinación de ambas modalidades. Diferencial: es histológicamente benigno; la extensión de la resección se balancea con la morbilidad de radioterapia y cirugía.

Divertículo de Meckel

Tarjeta 1 -- FRENTE: Enuncie la "regla de los 2" del divertículo de Meckel.

REVERSO: Incidencia del 2% (solo el 2% sintomático), diagnóstico antes de los 2 años, a 2 pies de la válvula ileocecal, con 2 pulgadas de longitud y 2 cm de diámetro. Diferencial: es un divertículo verdadero (contiene todas las capas) en el borde antimesentérico del íleon terminal.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Mecanismo del sangrado gastrointestinal masivo e indoloro en el divertículo de Meckel.

REVERSO: Tejido gástrico heterotópico cuya secreción ácida produce ulceraciones de la mucosa ileal adyacente. Diferencial: el sangrado por intususcepción cursa con dolor cólico y "jalea de grosella".

Tarjeta 3 -- FRENTE: Estudio de elección para diagnosticar el divertículo de Meckel sintomático.

REVERSO: Gammagrama con tecnecio-99m (gammagrama de Meckel), que marca selectivamente la mucosa gástrica ectópica productora de ácido. Complemento: ultrasonido y enteroclisia con bario.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Tratamiento del divertículo de Meckel sintomático con índice de sospecha alto.

REVERSO: Investigación quirúrgica o laparoscópica obligada; resección del divertículo con anastomosis término-terminal. Diferencial: la diverticulitis de Meckel simula apendicitis; el punto guía para intususcepción o vólvulo es el propio divertículo.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Dos complicaciones mecánicas del divertículo de Meckel distintas del sangrado.

REVERSO: Intususcepción (el divertículo actúa como punto guía) y vólvulo (el intestino adyacente rota sobre su vasculatura). La diverticulitis puede simular apendicitis.

Fibrosis Quística

Tarjeta 1 -- FRENTE: Relación entre fibrosis quística y enfermedad hemorrágica del recién nacido (según la nota de la bóveda).

REVERSO: La fibrosis quística es causa de la forma tardía de la enfermedad hemorrágica del recién nacido, por deficiencia de vitamina K secundaria a malabsorción. Diferencial: otras causas de la forma tardía son ictericia colestásica, síndrome de malabsorción y deficiencia de alfa-1 antitripsina.

Tarjeta 2 -- FRENTE: La nota del vault sobre fibrosis quística: ¿contiene desarrollo clínico completo?

REVERSO: No: es un borrador que solo remite a la parte 9 del volumen I del Manual Dr. Prieto (14a ed.), no disponible en el extracto procesado; la definición, etiología, clínica, diagnóstico y tratamiento quedan pendientes de completar. Diferencial: la única asociación documentada en esta nota es la malabsorción de vitamina K.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Qué sección de la fuente curada desarrolla la fibrosis quística según la nota de la bóveda?

REVERSO: La parte 9 del volumen I del Manual Dr. Prieto ENARM 14a ed.; el extracto de la sección de Pediatría solo contiene la remisión cruzada textual, sin datos clínicos. Diferencial: por regla de no inventar, no se añaden criterios, dosis ni hallazgos no presentes en la fuente.

Comunicaciones Auriculoventriculares

Tarjeta 1 -- FRENTE: Síndrome genético presente en el 30-60% de los pacientes con defectos de los cojinetes endocárdicos (comunicaciones auriculoventriculares).

REVERSO: Síndrome de Down (trisomía 21): el 30-60% de los casos. Diferencial: son cardiopatías acianógenas que representan el 3-5% de todas las cardiopatías congénitas.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Hallazgo electrocardiográfico característico de las comunicaciones auriculoventriculares.

REVERSO: Eje eléctrico superior (desviación izquierda), con o sin hipertrofia ventricular derecha e izquierda. Diferencial: este eje superior es la clave frente a la CIA ostium secundum, que desvía el eje a la derecha.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Tratamiento inicial de la insuficiencia cardíaca congestiva en las comunicaciones auriculoventriculares y solución definitiva.

REVERSO: Digoxina y diuréticos como manejo inicial; generalmente se requiere cierre quirúrgico. Diferencial: es un defecto de los cojinetes endocárdicos con afectación de las válvulas auriculoventriculares.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Hallazgo auscultatorio típico de la comunicación auriculoventricular y su localización.

REVERSO: Soplo regurgitante holosistólico de intensidad 3-4/6 en el borde esternal inferior izquierdo, con área cardíaca hiperdinámica y S2 intenso; puede acompañarse de soplo de insuficiencia mitral en el ápex y ritmo de galope.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Radiografía de tórax en las comunicaciones auriculoventriculares.

REVERSO: Cardiomegalia con aumento de los patrones vasculares pulmonares (cortocircuito izquierda-derecha). Diferencial: pertenecen al grupo acianógeno; el ECG con eje superior las distingue de la CIA.

Comunicación Interventricular (CIV)

Tarjeta 1 -- FRENTE: Cardiopatía congénita más común a nivel mundial y su frecuencia relativa.

REVERSO: Comunicación interventricular (CIV): 20-25% de todas las cardiopatías congénitas. Diferencial: la CIA es la más frecuente aislada en el adulto; la CIV lo es en la infancia.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Soplo característico de la comunicación interventricular y su localización.

REVERSO: Holosistólico de intensidad 2-5/6 en el borde esternal inferior izquierdo, con irradiación en barra; puede añadir retumbo apical diastólico si el cortocircuito es grande. Diferencial: la CIA da soplo sistólico de eyección en borde esternal superior izquierdo con S2 desdoblada y fija.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Estudio de elección para el diagnóstico de la CIV.

REVERSO: Ecocardiograma transtorácico con Doppler. Diferencial: la radiografía muestra cardiomegalia y acentuación de trama vascular pulmonar en grado dependiente del cortocircuito izquierda-derecha.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Manejo de la CIV según tamaño del defecto (pequeño, moderado, indicaciones de cierre).

REVERSO: Pequeño: no requiere cierre, solo profilaxis de endocarditis. Moderado: agrega diuréticos y digoxina. Cierre quirúrgico o por cateterismo si hay falla de medro o hipertensión pulmonar persistente. Diferencial: no corregida puede evolucionar a síndrome de Eisenmenger.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Complicación tardía de la CIV con cortocircuito izquierda-derecha no corregido.

REVERSO: Síndrome de Eisenmenger: hipertensión pulmonar irreversible con inversión del cortocircuito a derecha-izquierda (cianosis). Diferencial: la ECG en defectos grandes muestra hipertrofia biventricular.

Anomalía de Ebstein

Tarjeta 1 -- FRENTE: Anomalía anatómica definitoria de la anomalía de Ebstein.

REVERSO: Desplazamiento y adherencia hacia el ventrículo derecho de las valvas septal y posterior displásicas de la válvula tricúspide, con "atrialización" de parte del ventrículo derecho. En su forma grave es cardiopatía cianótica.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Dos fármacos administrados durante el embarazo que se asocian con anomalía de Ebstein.

REVERSO: Litio y difenilhidantoína (fenitoína). Diferencial: representan menos del 1% de las cardiopatías congénitas (1-5 por 200,000 nacidos vivos).

Tarjeta 3 -- FRENTE: Arritmia o anomalía de conducción clásicamente asociada a la anomalía de Ebstein.

REVERSO: Taquiarritmias por vías accesorias tipo síndrome de Wolff-Parkinson-White. En el ECG: bajo voltaje del QRS, bloqueo de rama derecha y bloqueo auriculoventricular de primer grado.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Tratamiento inicial del recién nacido con forma grave de anomalía de Ebstein y cianosis extrema.

REVERSO: Prostaglandinas para mantener el flujo ductal y óxido nítrico inhalado; posteriormente anticoagulación con warfarina (predisposición tromboembólica) y profilaxis de endocarditis. Definitivo: reparación o reemplazo valvular quirúrgico.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Hallazgo radiológico característico en el neonato sintomático con anomalía de Ebstein.

REVERSO: Cardiomegalia moderada o severa con índice cardiorácico >0.85. Diferencial: la insuficiencia cardíaca es la forma habitual de presentación en lactantes y niños.

Galactosemia

Tarjeta 1 -- FRENTE: Herencia y gen responsable de la galactosemia clásica.

REVERSO: Autosómica recesiva por mutaciones del gen GALT (galactosa-1-fosfato uridiltransferasa); en México predominan las mutaciones Q188R y N314D (71%). Diferencial: el tipo 2 es por deficiencia de galactosa cinasa (GALK) y el tipo 3 de epimerasa (GALE).

Tarjeta 2 -- FRENTE: Lactante con vómito, diarrea, ictericia, hepatomegalia, catarata y encefalopatía tras iniciar lactancia materna. Diagnóstico y tronco de la alteración enzimática.

REVERSO: Galactosemia clásica (deficiencia de GALT) con intoxicación por galactosa al iniciar la leche. Datos de órganos: hepáticos (hiperbilirrubinemia, coagulopatía), renales (aminoaciduria), oftalmológicos (catarata) e inmunológicos (sepsis).

Tarjeta 3 -- FRENTE: Hallazgo del tamiz neonatal que orienta a galactosemia y prueba que confirma el diagnóstico.

REVERSO: Galactosa total ≥ 10 mg/dl en el tamiz neonatal (caso probable); confirmación con actividad de GALT y concentración de galactosa-1-fosfato en eritrocitos (ensayo enzimático/espectrofotométrico, estándar

de oro).

Tarjeta 4 -- FRENTE: Tratamiento de la galactosemia clásica.

REVERSO: Dieta restringida en galactosa: la lactancia materna está absolutamente contraindicada y se sustituye por fórmula a base de proteína de soya. Diferencial: en fenilcetonuria no está contraindicada la lactancia; se agregan fórmulas libres de fenilalanina sin retirar las tetadas.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Secuelas tardías de la galactosemia a pesar del tratamiento.

REVERSO: Falla para crecer, dispraxia verbal y disfunción ovárica con hipogonadismo hipergonadotrópico. Diferencial: la catarata y la susceptibilidad a sepsis son manifestaciones tempranas de la intoxicación.

Coartación Aórtica

Tarjeta 1 -- FRENTE: Hallazgo semiológico fundamental para sospechar coartación aórtica en la exploración pediátrica.

REVERSO: Diferencia de pulsos entre miembros superiores e inferiores (pulsos femorales débiles o ausentes); es indispensable palpar pulsos femorales en toda exploración pediátrica. Diferencial: la coartación representa el 5-8% de las cardiopatías congénitas.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Recién nacido con insuficiencia cardíaca severa y coartación aórtica severa: fármaco indicado antes de la corrección quirúrgica y su objetivo.

REVERSO: Prostaglandina E1, para mantener permeable el conducto arterioso previo a la cirugía. Diferencial: en hipertensión arterial del paciente con coartación se emplean betabloqueadores e inhibidores de la ECA.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Signos radiológicos de la coartación aórtica en la radiografía de tórax.

REVERSO: Signo de Roesler: muescas en el tercio posterior de las costillas 3 a 8 por erosión de arterias colaterales dilatadas; signo del 3 por indentación aórtica en el sitio de la coartación (en esofagograma con bario, 3 invertido o signo de la E).

Tarjeta 4 -- FRENTE: Estudio diagnóstico fundamental para detectar la coartación aórtica.

REVERSO: Ecocardiograma Doppler. Diferencial: la coartación se asocia con síndrome de Turner, Williams-Beuren, rubéola congénita, neurofibromatosis y arteritis de Takayasu.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Indicaciones quirúrgicas en la coartación aórtica según gradiente transcoartación.

REVERSO: Gradiente pico-pico >20 mmHg; o gradiente <20 mmHg con imagen anatómica de coartación significativa y evidencia radiológica de circulación colateral significativa.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Síndrome genético clásicamente asociado a coartación aórtica en la mujer.

REVERSO: Síndrome de Turner. Diferencial: relación hombre:mujer de 1.5:1 en la población general con coartación.

Comunicación Interauricular (CIA)

Tarjeta 1 -- FRENTE: Cardiopatía congénita más frecuente en el adulto y su frecuencia relativa global.

REVERSO: Comunicación interauricular (CIA): 10-15% de todas las cardiopatías congénitas y la más frecuente de forma aislada en adolescentes y adultos. Diferencial: la CIV es la más común en la infancia (20-25%).

Tarjeta 2 -- FRENTE: Subtipo de CIA que representa el 70% de los defectos interauriculares y su hallazgo auscultatorio distintivo.

REVERSO: CIA ostium secundum: desdoblamiento amplio y fijo de S2 con soplo sistólico de eyección 2-3/6 en el borde esternal superior izquierdo; puede haber retumbo mesodiastólico en el borde esternal inferior izquierdo.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Hallazgo electrocardiográfico característico de la CIA y su distinción con las comunicaciones auriculoventriculares.

REVERSO: En defectos grandes: desviación del eje a la derecha con hipertrofia ventricular derecha leve o bloqueo de rama derecha. Diferencial: los defectos de cojinetes endocárdicos cursan con eje eléctrico superior.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Estándar de oro diagnóstico para la CIA.

REVERSO: Ecocardiograma Doppler transtorácico. La angiorresonancia magnética es la prueba de referencia para valorar la función ventricular.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Indicaciones de cierre de la CIA y vía de elección según el diámetro del defecto.

REVERSO: Cierre si: síndrome platipnea-ortodeoxia, embolismo paradójico, necesidad de plastia, resistencias pulmonares <5 unidades Wood o hipertensión pulmonar con Qp/Qs >1.5:1. Diámetro <38 mm: dispositivo percutáneo; mayor: cirugía.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Complicación evolutiva de la CIA no corregida con hipertensión pulmonar irreversible.

REVERSO: Síndrome de Eisenmenger (inversión del cortocircuito izquierda-derecha a derecha-izquierda con cianosis). Diferencial: en el postquirúrgico inmediato el riesgo principal son arritmias.

Epididimitis (Pediátrica)

Tarjeta 1 -- FRENTE: Agente etiológico de la epididimitis según grupo de edad: lactante, prepúber y adolescente sexualmente activo.

REVERSO: Lactante: infección viral (la más común). Prepúberes: coliformes de la vía urinaria. Adolescente sexualmente activo: Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae. Diferencial: grupos más afectados son lactantes <1 año y adolescentes de 12-15 años.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Signo clínico que distingue la epididimitis de la torsión testicular en la exploración escrotal.

REVERSO: Reflejo cremasteriano presente y signo de Prehn positivo (alivio del dolor con elevación testicular). Diferencial: en torsión testicular el reflejo cremasteriano está abolido y el signo de Prehn es negativo; su diferenciación es el primer objetivo y la torsión es urgencia urológica.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Tratamiento antibiótico empírico de la epididimitis en el adolescente con prácticas sexuales de riesgo.

REVERSO: Dosis única de ceftriaxona o azitromicina, seguida de mantenimiento por 14 días con doxiciclina. En niños con piuria o urocultivo positivo: trimetoprim-sulfametoxazol. Diferencial: indicar reposo 7-14 días.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Ultrasonido Doppler testicular en el dolor escrotal agudo pediátrico: ¿cuándo se reserva?

REVERSO: Se reserva para los casos sospechosos de torsión testicular; la GPC no recomienda exámenes paraclínicos rutinarios en la epididimitis aguda por su baja utilidad. En adolescentes de riesgo: exudado uretral, tinción de Gram, serología VIH y urocultivo.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Indicaciones para referir al segundo o tercer nivel un caso de epididimitis.

REVERSO: Duración >6 semanas, sospecha de torsión testicular (urgencia urológica) y asociación con anomalías del tracto urinario. Diferencial: complicaciones posibles incluyen absceso epididimario, azoospermia y dolor crónico.

Atresia Esofágica

Tarjeta 1 -- FRENTE: Tipo más frecuente de atresia esofágica según la clasificación de Vogt-Gross y su porcentaje.

REVERSO: Tipo C: atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal (85% de los casos). Diferencial: el tipo A es atresia sin fístula (7%) y el tipo E es fístula en "H" sin atresia.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Hallazgo prenatal más frecuente que sugiere atresia esofágica.

REVERSO: Polihidramnios (detectable después de la semana 18 de gestación). Diferencial: en el neonato hay salivación excesiva, tos, cianosis y dificultad respiratoria al alimentarse.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Primer momento en que se sospecha la atresia esofágica durante la atención del recién nacido y signo imagenológico de confirmación.

REVERSO: Cuando no pasa la sonda en la verificación de permeabilidad esofágica. Confirmación: radiografías AP y laterales de tórax y cuello con sonda radio-opaca o contraste hidrosoluble (0.5-1 mL): sonda enrollada en el cabo esofágico proximal sin paso de contraste.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Asociación sindrómica que incluye atresia esofágica y su componente más frecuente de anomalías asociadas.

REVERSO: Asociación VACTERL (Vertebrales, Anorrectales, Cardíacas, Traqueales/Esofágicas, Renales y de Extremidades), presente hasta en 10% de los pacientes. Las anomalías más comunes son cardíacas (35%: CIV y tetralogía de Fallot); 50-60% presenta alguna anomalía asociada.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Tratamiento quirúrgico de la atresia esofágica.

REVERSO: Corrección anatómica por toracotomía: cierre y ligadura de las fístulas y aproximación de los cabos esofágicos. Diferencial: secuelas frecuentes incluyen reflujo gastroesofágico, estrechamiento anastomótico y traqueomalacia.

Apendicitis (Pediátrica)

Tarjeta 1 -- FRENTE: Evolución clásica del dolor en la apendicitis pediátrica.

REVERSO: Dolor visceral periumbilical con náusea, vómito y fiebre, que migra a la fosa iliaca derecha (dolor somático por irritación peritoneal) antes de 24 horas, con defensa, rigidez e hipersensibilidad de rebote. Diferencial: la migración al cuadrante inferior derecho es la manifestación más sensible.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Leucocitosis esperada en la apendicitis pediátrica (cifra GPC) y diferencia con el punto de corte en adultos.

REVERSO: En niños: leucocitosis desde 15,000 células/ μ L con neutrofilia, con o sin bandemia. En adultos el punto de corte es 10,000 células/ μ L. Diferencial: la perforación suele ocurrir 24-48 horas después del inicio (alrededor de 36 horas en estudios recientes).

Tarjeta 3 -- FRENTE: "Prueba triple" de laboratorio para apendicitis (criterios de positividad).

REVERSO: Proteína C reactiva >8 μ g/mL, leucocitos $>11,000$ células/ μ L y neutrofilia $>75\%$. Diferencial: la escala MANTRELS (Alvarado modificada) otorga 2 puntos al dolor en cuadrante inferior derecho y al rebote; 7-10 puntos es riesgo alto.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Estudio de imagen de obtención obligada ante sospecha de apendicitis pediátrica y conducta ante cuadro clínico sugestivo.

REVERSO: Ultrasonido abdominal; todo paciente con cuadro sugestivo se refiere a segundo nivel para evaluación quirúrgica inmediata y valoración de apendicectomía, con ayuno, soluciones y antibióticos intravenosos.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Tratamiento de la apendicitis pediátrica según estado del apéndice (antes vs después de la perforación).

REVERSO: Antes de la perforación: apendicectomía simple. Después de la perforación: tratamiento antibiótico posquirúrgico parenteral de amplio espectro. Diferencial: es la emergencia quirúrgica más común en la niñez, con pico en la adolescencia tardía; solo el 5% ocurre en menores de 5 años.

Amigdalectomía en el Paciente Pediátrico

Tarjeta 1 -- FRENTE: Dos indicaciones absolutas de amigdalectomía en el paciente pediátrico.

REVERSO: Obstrucción de la vía aérea superior por hipertrofia amigdalina grado III-IV y amigdalitis recurrente documentada por criterios de Paradise. Diferencial: entre las relativas están absceso periamigdalino, tumor amigdalino y dos crisis convulsivas febriles.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Criterios de Paradise para amigdalectomía por faringoamigdalitis recurrente (frecuencia mínima).

REVERSO: ≥ 7 episodios en un año, o ≥ 5 episodios/año durante 2 años consecutivos, o ≥ 3 episodios/año durante 3 años consecutivos, más odinofagia con temperatura $>38^{\circ}\text{C}$, adenopatía cervical $>2\text{ cm}$, exudado o cultivo positivo para *S. pyogenes*, con antibióticos adecuados y episodios documentados.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Clasificación de la hipertrofia amigdalina que indica amigdalectomía por obstrucción.

REVERSO: Grado 3+ (obstrucción 50-74%) y grado 4+ ($\geq 75\%$ del espacio transversal de la orofaringe). Diferencial: grado 2+ corresponde a 25-49% y grado 1+ a menos del 25%.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Complicación más frecuente de la amigdalectomía.

REVERSO: Hemorragia (junto con faringodinia y edema, entre las complicaciones potenciales más frecuentes). Diferencial: la técnica fría (dissección) tiene mayor sangrado quirúrgico; la caliente (diatermia) requiere más analgésicos posquirúrgicos.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Casos que deben referirse al tercer nivel antes de una amigdalectomía.

REVERSO: Coagulopatías y enfermedades hematológicas, enfermedades metabólicas, anomalías craneofaciales, síndrome de Down u otros estados mórbidos especiales.

Enfermedad de Hirschsprung

Tarjeta 1 -- FRENTE: Causa más frecuente de obstrucción intestinal distal en el recién nacido y su sustrato histológico.

REVERSO: Enfermedad de Hirschsprung (megacolon agangliónico): ausencia de células ganglionares en los plexos de Meissner y Auerbach del segmento agangliónico, que no se relaja. Diferencial: afecta principalmente rectosigmoides; se asocia con síndrome de Down (frecuente) y gen RET.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Dato cronológico del meconio que sugiere enfermedad de Hirschsprung en el neonato.

REVERSO: Falta de eliminación de meconio en las primeras 48 horas de vida (a las 48 h, 100% de los RN normales ya lo eliminaron; el 45-90% de los enfermos no). Diferencial: el paso de heces en los primeros dos días no excluye el diagnóstico.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Signo clínico tras el tacto rectal característico de la enfermedad de Hirschsprung.

REVERSO: Signo del chorro o del estallido: expulsión explosiva de gas y heces líquidas después del tacto rectal, que alivia temporalmente la obstrucción. Diferencial: el cuadro neonatal es vómito, distensión abdominal y falta de evacuación.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Estándar de oro diagnóstico de la enfermedad de Hirschsprung y su técnica.

REVERSO: Biopsia rectal (idealmente a 3 cm de la línea dentada): ausencia de células ganglionares en el plexo submucoso con tinción de hematoxilina-eosina. Complemento: radiografía simple de abdomen (estudio

inicial), colon por enema y manometría anorrectal.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Gen predominantemente afectado en la enfermedad de Hirschsprung.

REVERSO: Protooncogén RET (mutaciones en ~50% de los casos familiares y un tercio de los esporádicos). Diferencial: es consecuencia de la falla de migración craneocaudal de células de la cresta neural.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Procedimiento quirúrgico clásico para la enfermedad de Hirschsprung.

REVERSO: Procedimiento de Swenson: resección del segmento agangliónico con descenso del intestino ganglionar normal y anastomosis proximal al ano, por arriba de la línea pectínea, preservando el esfínter anal interno. Diferencial: la enterocolitis es la complicación grave que aumenta la mortalidad (20-43% en México).

Atresia de Vías Biliares

Tarjeta 1 -- FRENTE: Momento en que debe sospecharse atresia de vías biliares en un recién nacido y tríada exploratoria a buscar.

REVERSO: Ictericia persistente después de la segunda semana de vida, con o sin acolia y coluria. En la exploración buscar intencionadamente: ictericia (signo fundamental), acolia y coluria. Diferencial: la ictericia fisiológica es transitoria y de bilirrubina indirecta.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Etiología más frecuente de colestasis crónica quirúrgica del lactante y primera indicación de trasplante hepático pediátrico.

REVERSO: Atresia de vías biliares. Diferencial: sin cirugía de Kasai la mortalidad es del 100% antes de los 3 años.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Tratamiento de elección de la atresia de vías biliares y ventana temporal óptima.

REVERSO: Cirugía de Kasai, realizada idealmente antes de los 60 días de vida (el pronóstico mejora si el diagnóstico es antes de los 45-60 días). Complemento: vitaminas A, D, E y K y estado nutricional. Sin tratamiento, sobrevida media de 8 meses.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Prueba de tamizaje con mayor rendimiento para sospecha de atresia de vías biliares y su rendimiento.

REVERSO: Colorimetría fecal: sensibilidad 97.1% y especificidad 99.9%. Diferencial: el gammagrama hepatobiliar tiene sensibilidad cercana al 100% y especificidad 85-95%; el ultrasonido, 85% y 80%.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Hallazgo de laboratorio típico de la atresia de vías biliares en pruebas hepáticas.

REVERSO: Hiperbilirrubinemia directa (con o sin elevación de enzimas hepáticas) con GGT elevada >300 U/L en el 90% de los casos. Diferencial: bilirrubina conjugada >20% del total con ictericia >2 semanas obliga a protocolo de estudio de colestasis.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Sexo y edad de presentación típicos de la atresia de vías biliares.

REVERSO: Predomina en el sexo femenino, entre las 4 semanas y los 4 meses de edad. Diferencial: es colangiopatía obliterativa fibro-inflamatoria progresiva que conduce a cirrosis temprana; etiología desconocida.

Fenilcetonuria

Tarjeta 1 -- FRENTE: Defecto enzimático, herencia y gen de la fenilcetonuria clásica.

REVERSO: Deficiencia de fenilalanina hidroxilasa (que convierte fenilalanina en tirosina); herencia autosómica recesiva, gen PAH en 12q22-24.1. Diferencial: la tirosina disminuye y la fenilalanina se eleva en plasma y orina.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Lactante con discapacidad intelectual, convulsiones, hipopigmentación y olor de la orina "a ratón". Diagnóstico.

REVERSO: Fenilcetonuria clásica: discapacidad intelectual como manifestación primordial (por toxicidad de fenilalanina), hipopigmentación por deficiencia de tirosina (menos melanina) y olor característico "a humedad", "a ratón" o "a paja mojada".

Tarjeta 3 -- FRENTE: Hallazgo del tamiz neonatal que orienta a fenilcetonuria y prueba que confirma el diagnóstico.

REVERSO: Fenilalanina ≥ 10 mg/dl en el tamiz neonatal (caso probable); confirmación con demostración de mutaciones del gen PAH por análisis molecular (estándar de oro). Diferencial: la galactosemia se confirma midiendo actividad de GALT en eritrocitos.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Objetivo de concentración sérica de fenilalanina con la dieta en la fenilcetonuria y urgencia del inicio del tratamiento.

REVERSO: Mantener fenilalanina de 1 a 6 mg/dl ($120-360 \mu\text{mol/L}$); el tratamiento debe iniciarse dentro de los primeros 20 días de vida para evitar discapacidad intelectual irreversible. Diferencial: enfermedad progresiva; el SNC es el primer órgano afectado.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Tratamiento de la fenilcetonuria y composición de la dieta.

REVERSO: Restricción dietética de fenilalanina (manejo dietético-nutricional): ~80% de las proteínas de aminoácidos sintéticos libres de fenilalanina y 20% de proteínas intactas de frutas y verduras; suplementación de ácidos grasos esenciales (DHA, EPA). Diferencial: la lactancia materna se mantiene, agregando fórmulas libres de fenilalanina sin retirar las tetadas.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Alternativa farmacológica a la restricción dietética en fenilcetonuria leve a moderada.

REVERSO: Tetrahidrobiopterina/sapropterina; la fenilalanina amoniaco liasa (pegvaliasa) está aprobada en adultos. Diferencial: la dieta mantiene fenilalanina de $120-360 \mu\text{mol/L}$ vigilada al menos 2 años.

Alergia a la Proteína de la Leche de Vaca

Tarjeta 1 -- FRENTE: Alimento más alergénico en pediatría y alimentos que causan el 90% de las reacciones mediadas por IgE.

REVERSO: La proteína de la leche de vaca es el alimento más alergénico. El 90% de las reacciones IgE-mediadas se debe a: leche de vaca, huevo, cacahuete, soya, trigo, pescado y mariscos. Diferencial: la prevalencia de alergia alimentaria es 6-8% en menores de 4 años.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Prueba considerada estándar de oro para el diagnóstico de alergia alimentaria y su contraindicación.

REVERSO: Reto oral doble ciego con alimentos; contraindicado en pacientes con reacciones anafilácticas previas por alimentos. Las pruebas cutáneas (sensibilidad 90%, especificidad 50%) y las IgE específicas séricas sirven para las reacciones agudas.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Tratamiento de la alergia a la proteína de la leche de vaca: primera y segunda línea de sustitución.

REVERSO: Retiro de la leche de vaca, calcio 1 g/día y lactancia materna exclusiva; si no hay mejoría tras 4 semanas: fórmula extensamente hidrolizada (primera línea) y fórmula a base de aminoácidos (segunda línea). Diferencial: no se recomienda leche de otros mamíferos por reactividad cruzada (90%).

Tarjeta 4 -- FRENTE: Manifestaciones cutáneas más frecuentes de la alergia alimentaria y manejo de la reacción anafiláctica.

REVERSO: Urticaria aguda de contacto y angioedema. Anafilaxia: secuencia ABCDE con adrenalina intramuscular urgente, broncodilatadores, glucocorticoides y antihistamínicos; reacciones leves se tratan con difenhidramina.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Criterios para referir al segundo nivel a un lactante con sospecha de alergia a la proteína de la leche de vaca.

REVERSO: Persistencia de síntomas tras eliminación estricta por 4 semanas (2 semanas si elimina leche en dieta materna con lactancia exclusiva), ausencia de ganancia ponderal, eccema o dermatitis atópica severos sin respuesta al tratamiento y reacciones sistémicas o respiratorias al consumo.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Prognóstico de la alergia a la proteína de la leche de vaca frente a otras alergias alimentarias.

REVERSO: Aproximadamente el 85% de los niños resuelven su hipersensibilidad a leche, huevo, trigo y soya en los primeros 3-5 años; la alergia a cacahuates, pescado y mariscos suele ser vitalicia.

Enfermedad Hemorrágica del Recién Nacido

Tarjeta 1 -- FRENTE: Factores de coagulación dependientes de vitamina K cuya deficiencia causa la enfermedad hemorrágica del recién nacido.

REVERSO: Factores II, VII, IX y X, además de las proteínas C y S (cofactor para su carboxilación). Diferencial: es coagulopatía adquirida; todos los RN tienen deficiencia relativa de vitamina K porque atraviesa pobremente la placenta.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Patrón de laboratorio característico de la EHRN (TP, TTPa, fibrinógeno, plaquetas).

REVERSO: Tiempo de protrombina prolongado, TTPa normal o ligeramente prolongado, fibrinógeno y plaquetas normales. Diferencial: en hemofilia el TP es normal y el TTPa prolongado; en CID también descienden plaquetas y fibrinógeno.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Criterio diagnóstico de laboratorio de la EHRN (INR y datos asociados).

REVERSO: INR ≥ 4 con al menos uno: plaquetas normales, fibrinógeno normal, normalización del TP tras vitamina K, o PIVKA elevado (proteínas inducidas por la ausencia de vitamina K).

Tarjeta 4 -- FRENTE: Formas clínicas de la EHRN con su momento de presentación y sitio de sangrado típico.

REVERSO: Temprana (0-24 h): sangrado grave, SNC, cefalohematoma. Clásica (2-7 días, la más común): tubo digestivo, cordón umbilical, venopunciones. Tardía (2-6 meses): SNC en 60%, con vómitos, fontanela abombada, palidez y convulsiones. Diferencial: la forma tardía se asocia a malabsorción (fibrosis quística, colestásis).

Tarjeta 5 -- FRENTE: Profilaxis universal de la enfermedad hemorrágica del recién nacido.

REVERSO: Vitamina K intramuscular en dosis única de 1 mg, preferentemente en las primeras 6 horas tras el nacimiento. Diferencial: la forma temprana se relaciona con fármacos maternos (warfarina, anticonvulsivantes, rifampicina, isoniazida).

Tarjeta 6 -- FRENTE: Tratamiento de la EHRN según la gravedad del sangrado.

REVERSO: Leve: vitamina K IV 1-2 mg. Severa: plasma fresco congelado (10-15 mL/kg) o concentrado de complejo protrombínico, además de vitamina K parenteral.

Estenosis Pilórica Hipertrófica

Tarjeta 1 -- FRENTE: Lactante de 4 semanas con vómito en proyectil no biliar postprandial y apetito voraz. Signo patognomónico a buscar en la palpación y su consecuencia sobre los estudios de gabinete.

REVERSO: Oliva pilórica en el epigastrio; según la GPC, si se palpa no es necesario ningún estudio de gabinete. Diferencial: el vómito no biliar distingue la estenosis pilórica de las atresias intestinales distales (vómito biliar).

Tarjeta 2 -- FRENTE: Alteración hidroelectrolítica característica de la estenosis pilórica hipertrófica.

REVERSO: Alcalosis metabólica hipoclorémica e hipocalémica; es la causa más común de alcalosis metabólica en pediatría. Diferencial: puede haber elevación del nitrógeno ureico e hiperbilirrubinemia no conjugada.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Estudio de primera elección para el diagnóstico de estenosis pilórica y sus criterios ecográficos.

REVERSO: Ultrasonido (sensibilidad 98%, especificidad 100%): diámetro pilórico total >15-18 mm, espesor del músculo >3-4 mm y longitud del canal >17 mm, con imagen de "doble riel". Diferencial: la serie esófago-gastroduodenal es segunda elección con signo de la cuerda.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Tratamiento de la estenosis pilórica hipertrófica.

REVERSO: Reposición hidroelectrolítica prequirúrgica (corregir alcalosis antes de operar) seguida de piloromiotomía de Fredet-Ramstedt, actualmente por laparoscopia. Diferencial: el desequilibrio hidroelectrolítico es causa principal de retraso de la cirugía.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Sexo, edad de presentación y fármaco materno/neonatal asociado a la estenosis pilórica.

REVERSO: Varones 4-5:1; se presenta entre las 2-8 semanas de vida (1 semana a 3 meses). Riesgo alto: eritromicina en las primeras 2 semanas de vida y macrólidos maternos en embarazo o lactancia. Diferencial: es la causa más frecuente de cirugía abdominal en menores de 2 meses.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Analgesia de elección en el posoperatorio de la piloromiotomía y principal complicación transquirúrgica.

REVERSO: Paracetamol como fármaco de elección; la principal complicación transquirúrgica es la perforación de la mucosa pilórica, que se repara con cierre primario y nueva piloromiotomía en otro punto de la circunferencia.

Displasia del Desarrollo de la Cadera

Tarjeta 1 -- FRENTE: Maniobras de exploración de la cadera del neonato y qué busca cada una.

REVERSO: Barlow: busca la luxabilidad de una cadera reducida. Ortolani: comprueba la reducción de una cadera previamente luxada. Diferencial: se exploran en el neonato y hasta ~3 meses; a los 3-6 meses predominan la limitación de la abducción y el signo de Galeazzi.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Método de escrutinio recomendado por la GPC en menores de 4 meses con riesgo de displasia de cadera.

REVERSO: Ultrasonografía. En mayores de 4 meses se indica ante sospecha clínica, limitación de la abducción o anomalías de la marcha; la radiografía cobra utilidad a partir de los 2 meses (líneas de Shenton, Hilgenreiner y Perkins, ángulo acetabular).

Tarjeta 3 -- FRENTE: Tratamiento de elección de la displasia del desarrollo de la cadera entre 1 y 6 meses de vida.

REVERSO: Posicionamiento en flexión y abducción con férulas, arnés de Pavlik o de Frejka, por un periodo no mayor a 3 meses. Diferencial: 6-24 meses requiere reducción cerrada con tenotomías; >24 meses, reducción abierta.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Grupo de mayor riesgo para displasia del desarrollo de la cadera.

REVERSO: Niñas con antecedentes familiares positivos y/o con presentación pélvica (riesgo alto). Diferencial: otros factores son primogénito, madre primigrávida y oligohidramnios; tortícolis muscular congénita y metatarso aducto se asocian.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Signo clínico de acortamiento de una pierna en el lactante con displasia de cadera unilateral.

REVERSO: Signo de Galeazzi. Diferencial: puede acompañarse de asimetría de pliegues cutáneos de los muslos y limitación a la abducción; en la displasia bilateral los signos clínicos pueden estar ausentes y hay marcha "de pato".

Tarjeta 6 -- FRENTE: Complicaciones del tratamiento quirúrgico de la displasia de cadera.

REVERSO: Necrosis avascular iatrogénica, redislocación, subluxación y displasia acetabular residual. Diferencial: la forma teratológica se debe a desorden neuromuscular (mielodisplasia, artrogriposis) o complejo sindrómico.

Atresia Intestinal (Duodenal y Yeyunal)

Tarjeta 1 -- FRENTE: Neonato con vómito biliar sin distensión abdominal desde el primer día de vida. Diagnóstico más probable y hallazgo radiológico.

REVERSO: Atresia duodenal: signo de la doble burbuja (gas en estómago y duodeno proximal). Diferencial: es la atresia intestinal más frecuente (25-40% de las atresias); fracaso de recanalización en la séptima semana de gestación.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Síndrome genético presente en cerca de un tercio de los neonatos con atresia duodenal con anormalidades cromosómicas.

REVERSO: Trisomía 21 (síndrome de Down): cerca de la mitad tiene anormalidades cromosómicas y un tercio son trisomía 21. Diferencial: 50% nacen prematuros; anomalías asociadas incluyen páncreas anular (30%) y cardiopatías (30%, única con incremento de mortalidad).

Tarjeta 3 -- FRENTE: Tratamiento quirúrgico de la atresia duodenal.

REVERSO: Duodenoduodenostomía, tras manejo inicial con sonda nasogástrica e hidratación parenteral; suele requerirse gastrostomía para drenaje gástrico. Diferencial: la corrección puede posponerse hasta resolver anomalías que amenacen la vida; supervivencia ~90%.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Mecanismo etiológico de las atresias yeyunal e ileal (vs duodenal).

REVERSO: Accidentes vasculares intrauterinos con infarto segmentario y resorción del intestino fetal (vólvulo, intususcepción, íleo meconial); la duodenal es por fracaso de recanalización. Diferencial: cada una representa el 20% de las atresias de intestino delgado.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Hallazgo radiológico esperado en la atresia yeyunal/ileal.

REVERSO: Niveles hidroaéreos múltiples proximales a la atresia (proyecciones de bipedestación y decúbito lateral). Diferencial: la atresia duodenal muestra doble burbuja sin niveles distales; se requieren contrastes para localizar el nivel.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Tratamiento definitivo de la atresia yeyunal.

REVERSO: Resección del intestino proximal dilatado con anastomosis término-terminal, tras reposición hidroelectrolítica y tratamiento de infecciones. Diferencial: el polihidramnios aparece en 20-35% y la distensión abdominal aparece en 12-24 horas tras iniciar alimentación.

Bronquiolitis

Tarjeta 1 -- FRENTE: Agente etiológico más común de la bronquiolitis y grupo de edad de máxima incidencia.

REVERSO: Virus sincitial respiratorio (VSR), hasta 80% de los casos en epidemias; afecta menores de 2 años con predominio entre 3 y 6 meses. Diferencial: es la causa más frecuente de hospitalización en lactantes (90%

de hospitalizados <12 meses).

Tarjeta 2 -- FRENTE: Diagnóstico de la bronquiolitis: ¿requiere estudios de imagen o laboratorio?

REVERSO: Es clínico (historia y exploración); no se recomienda radiografía ni estudios sanguíneos salvo sospecha de otro proceso. Solo oximetría de pulso para monitorizar saturación. Diferencial: la radiografía, si se hace, muestra hiperinsuflación y aplanamiento diafragmático.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Terapéutica nebulizada recomendada en la bronquiolitis y criterio para usar salbutamol según la GPC.

REVERSO: Solución salina hipertónica al 3% nebulizada (moviliza agua, reduce edema y viscosidad del moco). Salbutamol solo si hay historia familiar de atopia, asma o alergia. Diferencial: no recomendados corticoides, ribavirina, antihistamínicos ni antibióticos.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Anticuerpo monoclonal para la prevención de bronquiolitis grave por VSR: indicaciones y vía.

REVERSO: Palivizumab, inyecciones mensuales iniciando antes de la temporada: menores de 2 años con displasia broncopulmonar grave, infantes de muy bajo peso y cardiopatías congénitas hemodinámicamente significativas.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Umbral de saturación de oxígeno que define bronquiolitis grave y manejo de soporte básico.

REVERSO: SpO₂ <92% corresponde a gravedad grave/muy grave. Soporte: oxígeno con cánulas nasales, hidratación, aspiración de secreciones, control térmico y paracetamol si T >38 °C.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Criterios GPC de referencia al segundo nivel en bronquiolitis.

REVERSO: Prematurez, edad <3 meses, bronquiolitis moderada o grave (4-7 puntos en escala de valoración), comorbilidad, intolerancia a la vía oral o evolución no favorable. Diferencial: 1-3 puntos es leve (ambulatorio); 8-14, grave.

Faringoamigdalitis Bacteriana

Tarjeta 1 -- FRENTE: Agente etiológico principal de la faringoamigdalitis bacteriana y su proporción frente al total de faringitis.

REVERSO: Streptococcus pyogenes (estreptococo betahemolítico del grupo A): 15-30% de las faringoamigdalitis; representa menos del 10% del total de casos de faringitis. Diferencial: >90% son virales, con predominio viral en menores de 3 años y bacteriano en escolares.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Componentes de los criterios de Centor modificados (Mclsaac) y su utilidad.

REVERSO: Temperatura >38 °C (+1), ausencia de tos (+1), adenopatías cervicales anteriores dolorosas (+1), hipertrofia o exudado amigdalino (+1), edad 3-14 años (+1), edad >44 años (-1). Con <2 puntos no se toma cultivo ni se dan antibióticos; con 3-5 puntos se inicia antibiótico (prueba rápida opcional).

Tarjeta 3 -- FRENTE: Tratamiento de primera línea de la faringoamigdalitis estreptocócica con dosis exactas.

REVERSO: Penicilina G benzatínica IM en dosis única: 600,000 UI si pesa <27 kg; 1,200,000 UI si >27 kg. Diferencial: en alérgicos a penicilina, eritromicina, TMP-SMX o cefalosporinas de primera generación; en fracaso terapéutico, clindamicina.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Objetivo principal del tratamiento antibiótico de la faringoamigdalitis estreptocócica.

REVERSO: Prevenir la fiebre reumática y las complicaciones supurativas. Diferencial: el estándar de oro diagnóstico es el cultivo de exudado faríngeo en agar sangre.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Medida para los contactos del caso índice de faringoamigdalitis estreptocócica.

REVERSO: Quimioprofilaxis de contactos con rifampicina. Diferencial: el control sintomático es con paracetamol, ibuprofeno o naproxeno.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Datos clínicos de referencia urgente al segundo nivel en faringoamigdalitis.

REVERSO: Cianosis, estridor, sialorrea, disfagia, dificultad respiratoria, epiglotitis o absceso periamigdalino/retrofaringeo (riesgo de obstrucción de la vía aérea). Diferencial: la mononucleosis y la enfermedad de Kawasaki forman parte del diagnóstico diferencial.

Defectos de la Pared Abdominal (Gastrosquisis y Onfalocele)

Tarjeta 1 -- FRENTE: Diferencia anatómica entre gastrosquisis y onfalocele.

REVERSO: Gastrosquisis: defecto pequeño a la derecha del cordón umbilical, sin membrana, con asas expuestas al líquido amniótico. Onfalocele: defecto central cubierto por membrana mesenquimal (amnios) con el cordón inserto en ella. Diferencial: onfalocele se asocia a anomalías en 50-75%; gastrosquisis solo 5-20%.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Marcador que permite diferenciar prenatalmente onfalocele de gastrosquisis.

REVERSO: Alfa-fetoproteína en el líquido amniótico: elevada solo en la gastrosquisis. Diferencial: el onfalocele requiere ecografía minuciosa por anomalías asociadas y cariotipo (trisomías 13, 18 y 21 en 25-50%).

Tarjeta 3 -- FRENTE: Síndromes asociados al onfalocele.

REVERSO: Beckwith-Wiedemann (macrosomía, macroglosia, visceromegalia, hipoglucemia, hemihipertrofia), asociación VACTERL, síndrome ECC y complejo OEIS. Diferencial: saco pequeño sin hígado en el saco predice fuertemente cariotipo anormal.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Manejo inicial inmediato del neonato con gastrosquisis.

REVERSO: Cubrir el intestino con cobertura plástica transparente justo después del nacimiento (evita pérdida de agua y calor y permite ver vólvulos), sonda nasogástrica y nutrición parenteral; cierre primario posible en 60-70%. Diferencial: el pronóstico de la gastrosquisis es mejor (supervivencia 90-95% vs 30-80% del onfalocele).

Tarjeta 5 -- FRENTE: Complicación intestinal asociada a la gastrosquisis y su impacto pronóstico.

REVERSO: Atresias intestinales (5-25% de los casos), secundarias a daño isquémico o mecánico del intestino eviscerado; constituyen variable independiente de mal pronóstico. Diferencial: la morbilidad es casi exclusivamente intestinal (disfunción, atrofia de vellosidades).

Tarjeta 6 -- FRENTE: Vía del nacimiento de los defectos de pared abdominal y manejo del embarazo en onfalocele con membrana íntegra.

REVERSO: Todos pueden nacer por vía vaginal sin añadir daño intestinal. En onfalocele con membrana íntegra, el embarazo debe llegar a término. Diferencial: en gastrosquisis el momento del nacimiento se decide para limitar el daño de las asas expuestas.

Asfixia Neonatal

Tarjeta 1 -- FRENTE: Criterios diagnósticos de asfixia neonatal en el recién nacido (criterios del manual).

REVERSO: Acidosis metabólica con pH <7.0 y/o déficit de base >12 en sangre de cordón; Apgar <3 a los 5 minutos; y alteraciones neurológicas y/o falla orgánica múltiple (≥2 órganos). Diferencial: 5-10% de los RN requieren algún grado de reanimación.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Neuroprotección de elección en la encefalopatía hipóxico-isquémica: objetivo, ventana y duración.

REVERSO: Hipotermia terapéutica (33-34 °C), iniciada en las primeras 6 horas de vida y mantenida durante 72 horas. Diferencial: ante crisis convulsivas se usan fenobarbital o difenilhidantoína.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Escala recomendada para evaluar gravedad y pronóstico de la encefalopatía hipóxico-isquémica.

REVERSO: Escala de Sarnat (3 etapas): etapa 1 hiperalerta con tono normal; etapa 2 letárgico/obnubilado con hipotonía y convulsiones comunes; etapa 3 estuporoso/coma, flácido y pupilas variables. Diferencial: la EHI requiere edad gestacional ≥ 35 semanas sin otra causa explicativa.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Distribución temporal de los eventos de asfixia neonatal.

REVERSO: 5% antes del trabajo de parto, 85% durante el parto y 10% en el periodo neonatal. Diferencial: el riesgo es inversamente proporcional a la edad gestacional; en México es la principal causa de muerte neonatal (49.4%).

Tarjeta 5 -- FRENTE: Estudios de imagen/electrofisiológicos recomendados en la EHI y su ventana de realización.

REVERSO: Ultrasonido transfontanelar y EEG multicanal en las primeras 24 horas de vida; resonancia magnética cerebral dentro de las primeras 72 horas. Diferencial: hasta el 60% de los RN con EHI mueren y el 25% de sobrevivientes queda con discapacidad significativa.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Mortalidad según la gravedad de la encefalopatía hipóxico-isquémica.

REVERSO: EHI leve: sin riesgo de mortalidad ni minusvalía moderada-severa; EHI moderada: mortalidad neonatal cercana al 3% (minusvalía 20-45%); EHI grave: mortalidad 50-75%, con secuelas neurológicas casi universales. Diferencial: perímetro cefálico bajo el percentil 3 en el seguimiento indica mal pronóstico.

Enterocolitis Necrosante

Tarjeta 1 -- FRENTE: Hallazgo radiológico patognomónico de la enterocolitis necrosante en la radiografía simple de abdomen.

REVERSO: Neumatosis intestinal (gas intramural) y/o gas en vena porta. Diferencial: el neumoperitoneo indica perforación (estadio IIIB); la radiografía se repite cada 6 horas en la fase aguda.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Clasificación clínica empleada para estadificar la enterocolitis necrosante.

REVERSO: Clasificación de Bell modificada: estadio I sospecha, estadio II confirmada (IIB con gas en vena porta, acidosis y trombocitopenia) y estadio III avanzada (IIIB con perforación). Diferencial: es la urgencia intestinal más frecuente del prematuro en UCIN.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Tratamiento antibiótico de la enterocolitis necrosante estadio II.

REVERSO: Ampicilina y gentamicina (empírico) por 7-10 días en IIA y 14 días en IIB, con escalonamiento según cultivos. No se recomienda metronidazol ni clindamicina en este estadio. Diferencial: en estadio I solo ayuno, monitoreo y antibióticos por 3 días.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Factor de riesgo más importante para enterocolitis necrosante y efecto protector de la alimentación.

REVERSO: Prematurez. La leche materna reduce la incidencia frente a la fórmula; la alimentación enteral temprana (24-48 h) en <34 semanas no incrementa el riesgo. Diferencial: los antibióticos >4 días sin diagnóstico de sepsis aumentan el riesgo.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Tratamiento inicial del prematuro $<1,000$ g con enterocolitis necrosante y perforación intestinal.

REVERSO: Drenaje peritoneal como tratamiento inicial (tubo de látex en cuadrante inferior derecho, izquierdo o ambos); aun así, hasta el 50% requerirá cirugía. Diferencial: en $>1,000$ g estables se prefiere laparotomía o laparoscopia de primera intención.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Complicaciones de la enterocolitis necrosante a mediano y largo plazo.

REVERSO: Perforación intestinal (con peritonitis) y síndrome de intestino corto tras resección amplia por necrosis. Diferencial: la trombocitopenia y la leucopenia son hallazgos frecuentes de laboratorio.

Aspiración e Ingestión de Cuerpo Extraño

Tarjeta 1 -- FRENTE: Lactante con ahogo agudo por cuerpo extraño: maniobras de primera respuesta en menores de 1 año.

REVERSO: 5 palmadas en la espalda seguidas de 5 compresiones torácicas, con la cabeza por debajo del tórax. No se recomiendan compresiones abdominales (lesión de órganos). Diferencial: en mayores de 1 año consciente se usa la maniobra de Heimlich.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Tratamiento definitivo de la aspiración de cuerpo extraño en el niño.

REVERSO: Remoción con broncoscopio rígido (método de elección); el flexible es alternativa. Diferencial: no se recomienda cricotirotomía en menores de 10 años; los barridos orofaríngeos con el dedo ya no se recomiendan.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Bronquio de localización más frecuente del cuerpo extraño aspirado.

REVERSO: Bronquio principal derecho (34%), seguido del izquierdo (29%) y tráquea (18%). Diferencial: la localización laringea o traqueal es menos frecuente pero con mayor morbilidad.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Hallazgo radiográfico más frecuente en la aspiración de cuerpo extraño y porcentaje de placas normales.

REVERSO: Hiperinsuflación en 42% de los casos (atelectasia en 27%); hasta 12% de las placas son normales. Diferencial: la tríada de sibilancias, tos y disminución de ruidos no está presente de forma universal.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Objeto ingerido de manejo emergente (<2 horas) por su riesgo de lesión por corrosión.

REVERSO: Batería discale en esófago: emergencia con extracción endoscópica. Los objetos puntiagudos también son emergencia. Diferencial: los imanes múltiples son urgencia; los romos >2.5 cm o >6 cm son urgencia.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Objetos ingeridos que improbablemente pasarán el píloro espontáneamente y requieren extracción endoscópica.

REVERSO: Objetos romos con diámetro >2 cm en menores de 1 año o >3 cm en mayores de 1 año, y longitud >6 cm. Diferencial: monedas son la ingestión más frecuente (61.7%); hasta 75% ocurre en menores de 5 años.

Desnutrición Infantil

Tarjeta 1 -- FRENTE: Diferencia clínico-metabólica entre marasmo y kwashiorkor.

REVERSO: Marasmo: deficiencia calórica, peso <60% del esperado, depleción somática (grasa y músculo) con albúmina normal o ligeramente baja, sin edema. Kwashiorkor: carencia proteica predominante con hipoalbuminemia y edema periférico, grasa subcutánea conservada. Diferencial: el edema distingue al kwashiorkor.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Clasificación de Gómez de la desnutrición por porcentaje del peso esperado para la edad.

REVERSO: Grado I (leve): 75-90%; grado II (moderada): 60-74%; grado III (grave): <60%. Diferencial: la GPC define desnutrición grave como peso/edad <60%, peso/talla <70% o perímetro braquial <115 mm.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Clasificación de Waterlow: indicadores y tipos de desnutrición que distingue.

REVERSO: Usa peso para la talla (P/T) y talla para la edad (T/E): aguda (P/T baja, T/E normal), crónica armonizada (P/T normal, T/E baja) y crónica agudizada (ambos bajos). Diferencial: el marasmo es desnutrición aguda severa; el kwashiorkor cursa con P/T aparentemente normal por edema.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Medición del perímetro braquial que indica desnutrición severa con referencia obligada.

REVERSO: Perímetro braquial <115 mm en niñas y niños de 6-59 meses (referencia a centro especializado); <133 mm sugiere desnutrición. Diferencial: el indicador epidemiológico más apropiado es la talla baja (talla para la edad).

Tarjeta 5 -- FRENTE: Aporte hídrico y proteico inicial en la desnutrición grave hospitalizada (GPC).

REVERSO: Hidratación: 100 mL/kg/día con edema y 130 mL/kg/día sin edema. Proteína: inicia 1-1.5 g/kg/día, incrementando progresivamente hasta 4-6 g/kg/día, en tomas pequeñas y frecuentes.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Complicaciones agudas que definen el manejo hospitalario de la desnutrición grave.

REVERSO: Hipoglucemia, anemia, hipotermia, infecciones, deshidratación y desequilibrio electrolítico. Diferencial: ganancia ponderal adecuada vigilada de 10 g/kg/día o 100 g/semana.

Dolor Abdominal Agudo (Pediátrico)

Tarjeta 1 -- FRENTE: Definición de abdomen agudo en pediatría.

REVERSO: Dolor abdominal severo, localizado o generalizado, que puede requerir evaluación e intervención quirúrgica urgente. Diferencial: en el recién nacido predomina el tipo oclusivo; conforme avanza la edad predominan causas infecciosas y traumáticas.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Primer estudio de gabinete en el abdomen agudo pediátrico y qué evalúa.

REVERSO: Radiografía abdominal: obstrucciones, estreñimiento, aire libre en cavidad (perforación), litos biliares y renales. Diferencial: la radiografía torácica se indica para investigar neumonía como causa extrabdominal.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Causas gastrointestinales del abdomen agudo pediátrico (mencione al menos cuatro).

REVERSO: Apendicitis, intususcepción, malrotación con vólvulo, obstrucción intestinal, pancreatitis, úlcera perforada, diverticulitis de Meckel, colecistitis, linfadenitis mesentérica y estreñimiento, entre otras.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Causas no gastrointestinales del abdomen agudo en el niño (renal, ginecológica, oncológica y otras).

REVERSO: Renal: IVU, pielonefritis, nefrolitiasis. Ginecológica: embarazo ectópico, torsión ovárica, EIP. Oncológica: tumor de Wilms, neuroblastoma. Otras: púrpura de Henoch-Schönlein, neumonía, cetoacidosis diabética, anemia drepanocítica.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Manejo inicial del abdomen agudo pediátrico.

REVERSO: Ayuno e hidratación; pueden añadirse descompresión nasogástrica, examen abdominal seriado, evaluación quirúrgica y ginecológica, y analgésicos o antibióticos según indicación. El tratamiento definitivo puede ser quirúrgico o endoscópico.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Estudios de laboratorio indicados en el abdomen agudo pediátrico.

REVERSO: Electrolitos, panel químico, hemograma, pruebas de función renal y hepática, coagulación, urianálisis, amilasa y lipasa, β -hCG, PCR y ESR, y PCR/cultivo de *N. gonorrhoeae* y *C. trachomatis* cuando aplique.

Enfermedad Diarreica Aguda

Tarjeta 1 -- FRENTE: Plan de hidratación (método de Dhaka) según el grado de deshidratación en la EDA.

REVERSO: Sin deshidratación: Plan A (SRO tras cada evacuación: 75 mL si <1 año, 150 mL si >1 año, más alimentación habitual y lactancia). Leve-moderada: Plan B (SRO 50-100 mL/kg en 4 horas). Grave/choque: Plan C (terapia intravenosa). Diferencial: el estándar de oro de gravedad es la comparación del peso antes y después de rehidratar.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Esquema de rehidratación intravenosa (Plan C) de la GPC mexicana vigente para choque hipovolémico por EDA.

REVERSO: Ringer-Lactato 100 mL/kg fraccionado en 3 horas: 50 mL/kg la primera hora, 25 mL/kg la segunda y 25 mL/kg la tercera; luego reevaluar para Plan A o B. Diferencial: el esquema OMS histórico (30 mL/kg en 30 min + 70 mL/kg en 5 h 30 min si <12 meses) también aparece documentado.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Signo físico con mayor razón de probabilidad positiva para deshidratación en la EDA.

REVERSO: Retardo del llenado capilar (LR = 4.1). Diferencial: el estándar de oro de la gravedad de la deshidratación es comparar el peso al ingreso con el peso tras la rehidratación.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Fármaco antiemético de elección en la EDA con vómitos y ventaja frente a la metoclopramida.

REVERSO: Ondansetrón: disminuye significativamente la emesis y mejora el éxito de la terapia de rehidratación oral. Diferencial: el racecadotril disminuye la cantidad de heces y el zinc reduce diarrea y muertes hasta 50%.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Tratamiento antibiótico de la shigelosis con dosis según GPC.

REVERSO: Azitromicina 12 mg/kg/día el primer día seguida de 6 mg/kg/día por 4 días más, VO (alternativa: ceftriaxona 50 mg/kg/día c/24 h por 2-5 días, IM). Diferencial: la disentería (sangre) sugiere Shigella, EHEC o Entamoeba.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Tratamiento de la giardiasis y de la amebiasis disenteriforme con dosis.

REVERSO: Giardiasis: metronidazol 15 mg/kg/día VO dividido en 3 dosis por 10 días (alternativa: albendazol 400 mg/día por 5 días). Amebiasis: metronidazol 30 mg/kg/día VO dividido en 3 dosis por 10 días. Diferencial: la colitis por C. difficile usa metronidazol 30 mg/kg/día por 10 días o vancomicina VO.

Anormalidades del Tracto Urinario y Genital

Tarjeta 1 -- FRENTE: Anomalía peneana congénita más frecuente, su diagnóstico y ventana quirúrgica ideal.

REVERSO: Hipospadias: meato uretral ventral y pene encorvado; diagnóstico clínico al nacimiento; cirugía reconstructiva después de los 6 meses, idealmente entre los 6 y 18 meses. Diferencial: si asocia testículos no palpables, pene <2 cm o fusión labioescrotal, descartar trastorno de la diferenciación sexual.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Estudio de elección para confirmar el diagnóstico y el grado de reflujo vesicoureteral.

REVERSO: Cistouretrograma miccional. Diferencial: el ultrasonido es el estudio inicial y el gammagrama renal con DMSA valora la corteza funcional y la cicatrización renal.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Grados de reflujo vesicoureteral con indicación obligada de profilaxis antibiótica y antibióticos de elección.

REVERSO: Grados IV y V (además de IVU recurrente, disfunción vesical o infantes que no controlan esfínteres). Antibióticos: nitrofurantoína y trimetoprim-sulfametoxazol. Diferencial: en grados I-III no se recomienda profilaxis generalizada; el manejo conservador es de primera elección.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Hallazgo urológico más frecuente en pediatría y su prevalencia según contexto (RN, hidronefrosis prenatal, pielonefritis).

REVERSO: Reflujo vesicoureteral: ~1% de los RN, 15% ante hidronefrosis prenatal y 25-40% en niños con pielonefritis aguda. Diferencial: en RN predomina en varones (2:1); en el resto de las edades, niñas (4-6:1).

Tarjeta 5 -- FRENTE: Anomalía congénita con repliegues de mucosa en el verumontanum, primera causa de enfermedad renal crónica y trasplante renal en la infancia.

REVERSO: Válvulas uretrales posteriores: causan megauréter, hidronefrosis bilateral, dilatación de uretra proximal, trabeculación vesical y displasia renal. Tratamiento: derivación temporal (vesicostomía) y electrofulguración de las válvulas.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Anomalía genital congénita más frecuente: prevalencia, riesgo de malignización y timing de orquidopexia.

REVERSO: Criptorquidia (1-3% de RN de término, 15-30% en prematuros). La persistencia tras el año aumenta 2-8 veces el riesgo de tumor gonadal (abdominal, seminoma); orquidopexia preferentemente antes de los 12 meses (máximo 18). Diferencial: laparoscopia diagnóstica es el estándar para testículos intraabdominales.

Hernias Diafragmáticas Congénitas

Tarjeta 1 -- FRENTE: Lactante con dificultad respiratoria en las primeras 24 horas de vida, abdomen excavado, tórax asimétrico y ruidos peristálticos en el hemitórax. ¿Diagnóstico más probable?

REVERSO: Hernia diafragmática congénita de Bochdalek. Diferencial: la hernia de Morgagni es retroxifoidea, <2% y suele ser un hallazgo incidental.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es la localización más frecuente del defecto en la hernia de Bochdalek y en qué semana de gestación falla el cierre del canal pleuroperitoneal?

REVERSO: Defecto posterolateral izquierdo (80% de los casos); falta de cierre del canal pleuroperitoneal en la semana 8, con retorno intestinal en la semana 10, que produce hipoplasia pulmonar.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Estudio de elección para confirmar en el posnatal una hernia diafragmática congénita.

REVERSO: Radiografía de tórax (con vísceras herniadas y desviación del mediastino). El diagnóstico prenatal se sospecha por ultrasonido antes de las 25 semanas.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Recién nacido con hernia diafragmática congénita en dificultad respiratoria: ¿cuál es el manejo inicial y qué maniobra está contraindicada?

REVERSO: Intubación orotraqueal de primera elección con sonda nasogástrica para descompresión gástrica. La ventilación con presión positiva mediante mascarilla está contraindicada (distiende vísceras herniadas).

Tarjeta 5 -- FRENTE: Hallazgos ultrasonográficos prenatales sugestivos de hernia diafragmática congénita.

REVERSO: Polihidramnios, ausencia de burbuja gástrica intraabdominal, desviación del mediastino e hidropesía fetal.

Hipotiroidismo Congénito

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿En qué día de vida se realiza el tamizaje neonatal de hipotiroidismo congénito en México y con qué prueba?

REVERSO: Medición de TSH entre los 3 y 5 días de vida (no más allá del día 12), por su bajo costo, alta sensibilidad y detección de hipotiroidismo subclínico.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Lactante con letargo, estreñimiento, macroglosia, hernia umbilical, piel moteada, fontanela posterior grande e ictericia de más de 3 días. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Hipotiroidismo congénito. Diferencial clave: la ictericia por hipotiroidismo persiste más de 3 días y se acompaña de estreñimiento y llanto tosco.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Criterios de laboratorio que confirman hipotiroidismo congénito primario según la GPC.

REVERSO: TSH >4 μ U/ml, T4 libre <0.8 ng/dl y T4 total <4 μ g/dl (disminución de T4 con elevación de TSH).

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Cuál es la causa más frecuente de hipotiroidismo congénito y su variedad más común dentro de ella?

REVERSO: Disgenesia tiroidea (85% de los casos); dentro de ella, la ectopia tiroidea (57%), seguida de agenesia (36%) e hipoplasia (5%). Dishormonogénesis: 15%.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Cuándo debe iniciarse el tratamiento del hipotiroidismo congénito confirmado para garantizar desarrollo intelectual excelente?

REVERSO: Con hormonas tiroideas preferentemente a los 15 días de vida; si inicia dentro del primer mes, la expectativa de desarrollo intelectual es excelente.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Estándar de oro para determinar la variedad (agenesia vs ectopia) en hipotiroidismo congénito confirmado.

REVERSO: Gammagrama tiroideo con I-123 o Tc-99m (complementado con ultrasonido tiroideo).

Infecciones Congénitas y Perinatales (TORCH y otras)

Tarjeta 1 -- FRENTE: Lactante con coriorretinitis, hidrocefalia y calcificaciones intracraneales corticales difusas. ¿Diagnóstico y agente?

REVERSO: Tríada de Sabin de la toxoplasmosis congénita (*Toxoplasma gondii*); al sumar retraso psicomotor se denomina tétrada de Sabin. Tratamiento: pirimetamina + sulfadiazina por 1 año con ácido fólico.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Neonato hijo de madre no inmunizada con sordera sensorineural, cataratas y persistencia del conducto arterioso. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Síndrome de rubéola congénita: tríada de Gregg (cardiopatía con PCA la más frecuente, sordera, cataratas); con microcefalia es tétrada de Gregg. Riesgo 0% después de la semana 16.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Infección congénita más común y principal causa infecciosa de sordera sensorineural congénita; sus calcificaciones son periventriculares.

REVERSO: Citomegalovirus (CMV). Calcificaciones periventriculares (vs corticales difusas de toxoplasmosis). Tratamiento: ganciclovir para frenar la pérdida auditiva.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Neonato con vesículas, convulsiones y queratoconjuntivitis que debutó entre los días 5 y 10 de vida. ¿Agente y tratamiento?

REVERSO: Virus herpes simple (VHS-2 en el 90%, adquirido en el canal del parto). Tratamiento: aciclovir; diagnóstico por cultivo o PCR de vesícula/LCR.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Tratamiento de primera elección de la sífilis congénita sintomática.

REVERSO: Penicilina G sódica cristalina intravenosa por 10 días. La benzatínica solo se admite en sífilis congénita asintomática con seguimiento asegurado.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Neonato con conjuntivitis purulenta de madre con infección gonocócica. ¿Tratamiento y complicación temida?

REVERSO: Ceftriaxona o cefotaxima (esta última si hay hiperbilirrubinemia) en monodosis más irrigación oftálmica. Complicación: queratitis con perforación corneal y ceguera.

Infección de Vías Urinarias en Pediatría

Tarjeta 1 -- FRENTE: Agente etiológico más frecuente de la infección de vías urinarias en pediatría.

REVERSO: Escherichia coli (60-80%), seguida de Proteus mirabilis (6-10%) y Klebsiella pneumoniae (3-5%).

Tarjeta 2 -- FRENTE: Lactante con fiebre >38.5 °C, escalofríos y dolor en flanco. ¿Forma clínica de IVU y conducta?

REVERSO: Pielonefritis aguda. Requiere examen general de orina y urocultivo previo al antibiótico empírico: cefalosporinas orales de tercera generación (cefixima) o gentamicina.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿En qué pacientes debe obtenerse la muestra de orina por catéter para urocultivo?

REVERSO: En todos los menores de 6 meses y en las niñas menores de 2 años. El urocultivo con antibiograma es el estándar de oro diagnóstico.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Tratamiento de elección de la cistitis aguda no complicada en mayores de 3 meses, con esquema y duración.

REVERSO: Trimetoprim-sulfametoxazol 8-12 mg de TMP/kg/día dividido en 2 dosis (o nitrofurantoína 5-7 mg/kg/día en 4 dosis), por 3-4 días.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Criterios que definen IVU recurrente en pediatría.

REVERSO: Al menos 3 episodios en 12 meses o 2 episodios en 6 meses. Recidiva: mismo agente dentro de las 2 semanas posteriores al tratamiento; reinfección: agente diferente.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Paciente de 4 años con fiebre que persiste a las 48 horas de antibiótico adecuado por IVU. ¿Qué estudio y cuándo?

REVERSO: Es una IVU atípica: ultrasonido renal durante la fase aguda (<2 años o IVU atípica) para buscar anomalías estructurales; el cistouretrograma miccional se reserva para IVU atípica/recurrente o lactantes tras el primer episodio.

Intususcepción Intestinal

Tarjeta 1 -- FRENTE: Lactante de 7 meses con episodios de llanto y palidez cada 20-30 minutos, vómito biliar y heces en jalea de grosella. ¿Diagnóstico más probable y tipo más frecuente?

REVERSO: Intususcepción intestinal, tipo ileocecólico (la más frecuente), típica de lactantes de 4-9 meses con predominio masculino 4:1.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Estudio de elección para demostrar y tratar una intususcepción intestinal sin datos de complicación.

REVERSO: Colon por enema (hidrostático o neumático), diagnóstico y terapéutico. La radiografía de abdomen es el estudio inicial y el ultrasonido un complemento.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Criterios que permiten intentar la descompresión por enema en la intususcepción.

REVERSO: Evolución <24 horas, ausencia de perforación, peritonitis o sepsis, sin oclusión intestinal alta ni rectorragia importante, y niños menores de 2 años.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Al lactante con intususcepción se palpa una masa alargada, ¿en qué región es más frecuente y qué la produce?

REVERSO: Masa en salchicha en cuadrante superior derecho o epigastrio, formada por el intususcepto telescópico dentro del intususcipiente.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Tras reducción completa por enema, ¿cuál es el riesgo de recurrencia de la intususcepción y la vigilancia requerida?

REVERSO: Riesgo de recurrencia de 5-10%; vigilancia de 24 horas tras la reducción. Si la reducción es incompleta o hay necrosis/perforación: cirugía urgente.

Laringotraqueobronquitis (Crup)

Tarjeta 1 -- FRENTE: Niño de 18 meses con tos perruna, estridor inspiratorio y disfonía de aparición nocturna. ¿Diagnóstico y agente más frecuente?

REVERSO: Laringotraqueobronquitis (crup), causada sobre todo por virus parainfluenza tipos 1, 2 y 3, y virus sincitial respiratorio; típicamente entre 6 meses y 3 años.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Hallazgo radiográfico cervical característico del crup.

REVERSO: Estrechamiento subglótico en radiografía cervical anteroposterior, conocido como signo de la aguja o de la torre.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Tratamiento farmacológico de piedra angular del crup, con dosis.

REVERSO: Dexametasona 0.6 mg/kg en dosis única (o prednisolona 1 mg/kg) en casos leves y moderados; los esteroides son la piedra angular del tratamiento.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Crup grave con estridor en reposo y agitación: ¿qué fármaco se agrega y en qué forma?

REVERSO: Epinefrina racémica aerosolizada (nebulizada); si no hay racémica, L-epinefrina (4 ámpulas de 1 mg nebulizadas), igual de efectiva y segura.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Complicación más común de la laringotraqueobronquitis.

REVERSO: Neumonía vírica; en inmunocomprometidos, neumonía por parainfluenza y neumonía bacteriana secundaria.

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Cuándo se indica oxígeno suplementario en el crup?

REVERSO: Solo en caso de deterioro clínico u oximetría de pulso <92%; evitar procedimientos que alteren la calma del paciente.

Lesiones Traumáticas de la Cabeza del Recién Nacido

Tarjeta 1 -- FRENTE: Neonato con edema difuso del cuero cabelludo presente al nacer, que cruza las líneas de sutura y fontanelas. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Caput succedaneum: acumulación de suero o sangre sobre el periostio, externa al periostio, por eso cruza suturas; presente al nacer y resuelve en pocos días.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Neonato de parto con fórceps: tumoración parietal fluctuante que aparece horas después del nacimiento y NO cruza las suturas. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Cefalohematoma: colección subperióstica (ruptura de vasos diploicos), limitada a un hueso, alcanza su tamaño máximo al tercer día; puede asociarse a fractura lineal no deprimida.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Complicación más frecuente del cefalohematoma y manejo prohibido.

REVERSO: Fractura craneal (la más frecuente); también hiperbilirrubinemia e hipercalcemia. La incisión o aspiración rutinarias están contraindicadas por riesgo de infección.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Neonato posparto instrumentado con palidez, hipotonía, masa fluctuante que cabalga sobre suturas y fontanelas, y descenso del hematocrito. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Hemorragia subgaleal (entre aponeurosis y periostio): el espacio puede recibir todo el volumen circulante (~250 ml) con choque hipovolémico, CID y mortalidad del 25%.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Tratamiento inicial de la hemorragia subgaleal del recién nacido.

REVERSO: Reposición pronta de volumen con plasma fresco o concentrados eritrocitarios; neurocirugía solo como último recurso ante deterioro sostenido.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Diferencia clave entre caput succedaneum y cefalohematoma en cuanto a suturas y momento de aparición.

REVERSO: Caput: sobre el periostio, cruza suturas, presente al nacer. Cefalohematoma: subperióstico, no cruza suturas, habitualmente aparece horas o días después.

Lesión Obstétrica del Plexo Braquial

Tarjeta 1 -- FRENTE: Neonato con brazo en aducción y rotación interna del hombro, codo extendido y pronado con flexión del carpo (posición de propina de mesero). ¿Diagnóstico y raíces?

REVERSO: Parálisis de Erb-Duchenne, lesión C5-C6 (a veces C7); es la presentación más frecuente (90% de las lesiones obstétricas del plexo braquial).

Tarjeta 2 -- FRENTE: Neonato con mano en garra y síndrome de Horner ipsilateral. ¿Diagnóstico y raíces afectadas?

REVERSO: Parálisis de Klumpke, lesión C8-T1 (2-3% de los casos); la raíz T1 produce síndrome de Horner (ptosis, miosis y anhidrosis facial ipsilateral).

Tarjeta 3 -- FRENTE: Tratamiento de primera elección de la lesión obstétrica del plexo braquial y momento de inicio.

REVERSO: Conservador con rehabilitación, iniciando después del día 7 de vida (evitar movilizar el miembro los primeros 7 días), con órtesis dinámicas y toxina botulínica tipo A si hay desequilibrio muscular.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Indicaciones de manejo quirúrgico en la lesión obstétrica del plexo braquial.

REVERSO: Avulsión de T1 con síndrome de Horner, parálisis total del brazo, y a los 3 o más meses de edad con ausencia de función muscular del deltoides, tríceps o bíceps.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Fractura más frecuente por trauma obstétrico y parálisis más común en el recién nacido.

REVERSO: Fractura de clavícula (la más frecuente) y parálisis del nervio facial (la parálisis más común).

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Cuál es la expectativa de recuperación con manejo conservador en la lesión obstétrica del plexo braquial?

REVERSO: Cerca del 90% recupera completamente entre los 3 y 6 meses con rehabilitación temprana sostenida (hasta los 4 años o más).

Malformaciones Anorrectales

Tarjeta 1 -- FRENTE: Recién nacido con ano imperforado y trisomía 21. ¿Qué variante de malformación anorrectal se asocia?

REVERSO: Ano imperforado sin fístula, presente en el 95% de los casos con trisomía 21; considerar siempre la secuencia VACTERL.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Recién nacido con meconio visible en el periné. ¿Qué tipo de malformación anorrectal indica?

REVERSO: Fístula recto-perineal; el meconio puede no ser evidente hasta las 16-24 horas de vida. El diagnóstico es clínico en 90-95% de los casos.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Malformaciones congénitas más frecuentes asociadas a las malformaciones anorrectales.

REVERSO: Urogenitales (67%) y cardíacas (40.7%); por ello la GPC solicita ultrasonido de vías urinarias, ecocardiograma y radiografías torácica y de columna lumbosacra.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Manejo inicial del recién nacido con malformación anorrectal y tratamiento quirúrgico de elección.

REVERSO: Primeras 24-48 horas: ayuno, líquidos intravenosos y sonda orogástrica a derivación. Cirugía: derivación intestinal mediante colostomía o reparación primaria con anoplastía / abordaje sagital posterior.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Hallazgo que confirma atresia anorrectal al intentar sondaje rectal.

REVERSO: Imposibilidad de introducir más de 3 cm de sonda (atresia anorrectal, 1% de las malformaciones anorrectales; el ano imperforado constituye el 99%).

Mononucleosis Infecciosa

Tarjeta 1 -- FRENTE: Adolescente con fiebre, tonsilofaringitis y linfadenopatía cervical. ¿Diagnóstico más probable, agente y vía de transmisión?

REVERSO: Mononucleosis infecciosa por virus Epstein-Barr (VEB), transmitido por saliva; incubación de 30-50 días. La tríada está presente en el 98% de los casos.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Adolescente con mononucleosis que recibió amoxicilina y desarrolla erupción rojo-parda o cobriza difusa. ¿Interpretación?

REVERSO: Erupción característica por amoxicilina en mononucleosis: dato clínico típico de infección por VEB, no es alergia verdadera a penicilina.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Criterios de laboratorio que confirman la mononucleosis infecciosa según la GPC.

REVERSO: Linfocitosis, linfocitos atípicos y serología positiva para VEB; trombocitopenia en el 25-50% de los pacientes.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Prueba de anticuerpos heterófilos en mononucleosis: sensibilidad, especificidad y limitación por edad.

REVERSO: Reacción de Paul-Bunnell: sensibilidad 85% y especificidad 100%; solo 10-30% de los menores de 2 años la desarrollan (50-75% entre 2-4 años).

Tarjeta 5 -- FRENTE: Tratamiento de la mononucleosis infecciosa.

REVERSO: Sintomático: hidratación adecuada más AINE (ibuprofeno) o paracetamol; en casos complicados puede considerarse aciclovir y esteroides.

Neumonía Adquirida en la Comunidad (Pediátrica)

Tarjeta 1 -- FRENTE: Niño de 3 meses a 18 años con NAC no grave, sin alergia a penicilina. ¿Tratamiento de primera elección?

REVERSO: Amoxicilina oral por 5 días con reevaluación. Con alergia a penicilina o sospecha de bacterias atípicas: macrólido o doxiciclina.

Tarjeta 2 -- FRENTE: NAC grave hospitalaria sin factores de riesgo para neumococo resistente. ¿Esquema empírico?

REVERSO: Penicilina G intravenosa (reevaluación a las 72 horas). Con factores de riesgo de *S. pneumoniae* resistente: cefalosporina de tercera generación (ceftriaxona o cefotaxima).

Tarjeta 3 -- FRENTE: Criterios que clasifican la NAC pediátrica como grave.

REVERSO: Dificultad respiratoria, saturación <90%, taquicardia para la edad, tiraje intercostal, incapacidad para alimentarse, letargo o quejido respiratorio (cualquiera presente = grave).

Tarjeta 4 -- FRENTE: Agente bacteriano más frecuente de la NAC pediátrica y agentes predominantes en el recién nacido.

REVERSO: Streptococcus pneumoniae (serotipos 14, 5 y 1) es la bacteria más frecuente. En recién nacidos: Streptococcus agalactiae, E. coli y Chlamydia trachomatis; después del primer mes predominan los virus (sincitial respiratorio).

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿En qué casos está indicada la radiografía de tórax en la NAC pediátrica?

REVERSO: Solo en NAC severa, diagnóstico incierto, NAC complicada o recurrente; no es necesaria en NAC no severa tratada de forma ambulatoria.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Definición de falla al tratamiento de la NAC y conducta ante derrame pleural >10 mm.

REVERSO: Falla: fiebre persistente más allá de 72 horas con antibiótico adecuado. Ante derrame >10 mm: toracocentesis con análisis del líquido pleural. Antitusivos y mucolíticos no se recomiendan.

Neuroblastoma

Tarjeta 1 -- FRENTE: Neoplasia extracraneal más frecuente en niños, derivada de células del sistema nervioso simpático.

REVERSO: Neuroblastoma; ~40% se origina en la médula suprarrenal y el resto en cadenas simpáticas (abdomen y mediastino posterior).

Tarjeta 2 -- FRENTE: Histología característica del neuroblastoma.

REVERSO: Células redondas, azules y pequeñas sobre fondo de neurópila, con rosetas de Homer-Wright e inmunotinción positiva para enolasa neuroespecífica.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Niño menor de 1 año con tumor primario localizado y diseminación limitada a piel, hígado o médula ósea. ¿Estadio?

REVERSO: Estadio 4S del sistema internacional de estadiaje del neuroblastoma (requiere involucramiento de médula ósea <10% de células nucleadas).

Tarjeta 4 -- FRENTE: Marcadores secretados por el neuroblastoma útiles como derivados neurogénicos.

REVERSO: Catecolaminas, enolasa neuroespecífica y ferritina; los tumores pueden madurar a ganglioneuroblastoma y luego a ganglioneuroma.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Pronóstico del neuroblastoma según extensión de la enfermedad.

REVERSO: Supervivencia global >70%: enfermedad localizada resecable con histología favorable >90%; con metástasis solo 20%. Tratamiento primario: quimioterapia con cirugía, radioterapia o ambas.

Onfalitis

Tarjeta 1 -- FRENTE: Neonato con eritema e induración alrededor del ombligo con supuración maloliente. ¿Diagnóstico y agente más frecuente?

REVERSO: Onfalitis; el agente más frecuente es Staphylococcus aureus, seguido de S. epidermidis, estreptococos del grupo A, E. coli y Proteus.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Qué medida reduce el riesgo de onfalitis al aplicarse en el cordón umbilical dentro de las primeras 24 horas?

REVERSO: Clorhexidina al 4% (recomendación de la GPC); la OMS recomienda secado natural cuando no hay acceso a antisépticos tópicos.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Onfalitis con zona de hiperemia y edema >5 mm. ¿Conducta?

REVERSO: Tratamiento intravenoso y derivación urgente a segundo nivel. Con área <5 mm sin datos sistémicos: mupirocina o neomicina local; <5 mm con datos sistémicos: antibióticos intravenosos y derivación.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Cuál es el principal factor de riesgo de onfalitis neonatal?

REVERSO: Prácticas no higiénicas del cuidado del cordón umbilical; más de un tercio de los casos se asocian a anaerobios (*Bacteroides fragilis*, *Peptostreptococcus*, *Clostridium*).

Tarjeta 5 -- FRENTE: Complicaciones graves de la onfalitis.

REVERSO: Septicemia, fascitis necrosante, complicaciones peritoneales (vómito biliar, distensión abdominal) y abscesos peritoneales o retroperitoneales.

Orquitis

Tarjeta 1 -- FRENTE: Niño con dolor y edema escrotal con alivio del dolor al elevar el testículo. ¿Signo y su significado?

REVERSO: Signo de Prehn positivo (alivio con elevación testicular), orientador de orquitis; en torsión testicular la elevación agrava el dolor. No sustituye la evaluación urgente.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Causa más frecuente de orquitis en niños.

REVERSO: Infección vírica, sobre todo por parotiditis; la orquitis bacteriana suele asociarse a epididimitis (orquiepididimitis).

Tarjeta 3 -- FRENTE: Adolescente sexualmente activo con orquitis: etiología presumible y esquema empírico según la GPC.

REVERSO: *Chlamydia trachomatis* y *Neisseria gonorrhoeae*: ceftriaxona o azitromicina en dosis única, seguido de doxiciclina por 14 días.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Complicación más frecuente de la orquitis y su frecuencia.

REVERSO: Atrofia testicular en el 60% de los testículos afectados; otros: trastornos de fertilidad (7%), hidrocele y piocele.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Tratamiento general de la orquitis en niños (no bacteriana).

REVERSO: Analgésicos, antiinflamatorios, reposo y suspensorio; reposo físico por 7-14 días y frío local. Los antibióticos solo ante piuria/urocultivo positivo (TMP-SMX) o práctica sexual de riesgo.

Otitis Externa

Tarjeta 1 -- FRENTE: Niño con otalgia, prurito y dolor al presionar el trago o jalar el pabellón auricular, conducto inflamado y macerado. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Otitis externa aguda (oído de nadador); inflamación difusa del conducto auditivo externo con síntomas de inicio rápido (48 horas). La fiebre es poco frecuente.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Agentes etiológicos más frecuentes de la otitis externa aguda.

REVERSO: *Pseudomonas aeruginosa* (20-60%) y *Staphylococcus aureus*; las infecciones polimicrobianas son comunes. Diferencial: en la OMA el dolor no se exacerba al manipular el pabellón.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Tratamiento de base de la otitis externa leve a moderada con membrana timpánica intacta.

REVERSO: Terapia ototópica con fluoroquinolona, con o sin corticoide (ciprofloxacino, ofloxacino, ciprofloxacino-dexametasona), por 7 días (hasta 14 si no resuelve).

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Qué tratamiento tópico está prohibido en otitis externa con membrana timpánica no intacta o de estado desconocido?

REVERSO: Agentes con aminoglucósidos o alcohol, por riesgo de ototoxicidad; deben usarse solo fluoroquinolonas.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Qué forma de otitis externa es grave, casi siempre por *Pseudomonas aeruginosa* y se describe en inmunodeficientes?

REVERSO: Otitis externa necrosante (maligna); requiere alta sospecha en niños con inmunodeficiencia.

Otitis Media Aguda

Tarjeta 1 -- FRENTE: Criterios diagnósticos de otitis media aguda según la GPC.

REVERSO: Tres criterios simultáneos: inicio agudo (48 horas previas), signos de inflamación de la membrana timpánica (hiperemia intensa o color amarillo) y líquido en oído medio (abombamiento, hipomotilidad u otorrea por perforación).

Tarjeta 2 -- FRENTE: Mejor herramienta clínica para confirmar líquido en oído medio en la OMA, con sus datos de rendimiento.

REVERSO: Otoscopia neumática: sensibilidad 94% y especificidad 80%; sin ella, combinar otoscopio simple con timpanómetro.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Bacteria más frecuente de la otitis media aguda pediátrica.

REVERSO: *Haemophilus influenzae* (34%), seguida de *Streptococcus pneumoniae* (29%) y *Moraxella catarrhalis*; los virus están presentes en el 41% de los casos.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Lactante menor de 2 años con OMA y fiebre de 38.5 °C. ¿Tratamiento de elección, dosis y duración?

REVERSO: Amoxicilina 80-90 mg/kg/día dividida en 2-3 dosis por 7 días (o 10-14 días si es menor de 2 años con factores de riesgo). Mayores de 2 años con cuadro leve: observación-vigilancia 48-72 horas.

Tarjeta 5 -- FRENTE: OMA con otorrea, recurrencia o antibióticos en las 6 semanas previas: esquema antibiótico de primera elección.

REVERSO: Amoxicilina/ácido clavulánico 80-90 mg/kg/día en 2-3 dosis. Alergia no grave: cefalosporina de 2a/3a generación; alergia severa con anafilaxia: claritromicina.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Complicación más frecuente de la otitis media aguda.

REVERSO: Mastoiditis; otras: colesteatoma, petrositis, absceso cerebral, empiema subdural y pérdida auditiva. OMA recurrente: 3 episodios en 6 meses o 4 en 12 meses.

Persistencia del Conducto Arterioso (PCA)

Tarjeta 1 -- FRENTE: Soplo mecánico continuo 1-4/6 en el borde esternal superior izquierdo con presión de pulso amplia en un lactante. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Persistencia del conducto arterioso (PCA): cortocircuito izquierda-derecha; cardiopatía congénita más frecuente en México. Diferencial: la CIV cursa con soplo sistólico holosistólico.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Estudio de elección para confirmar el diagnóstico de PCA.

REVERSO: Ecocardiograma Doppler a color con proyección en eje corto; también identifica cardiopatías asociadas (CIV, CIA, estenosis aórtica o pulmonar, válvula aórtica bivalva).

Tarjeta 3 -- FRENTE: Cierre farmacológico del conducto arterioso en la etapa neonatal: fármacos utilizados.

REVERSO: AINE inhibidores de prostaglandinas: ibuprofeno oral, paracetamol o indometacina (intravenosa u oral; en México no hay presentación intravenosa de ibuprofeno).

Tarjeta 4 -- FRENTE: Indicaciones de cierre quirúrgico de la PCA.

REVERSO: Falla del tratamiento farmacológico, en lactantes o edades mayores, con síntomas, sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo o hipertensión pulmonar con presión sistólica pulmonar $<2/3$ de la sistémica.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Cuándo se programa el cierre electivo de la PCA en pacientes asintomáticos según la GPC mexicana?

REVERSO: A los 2 años de edad o cuando el niño pese 10-12 kg (lo que ocurra primero). Contraindicado si hay hipertensión pulmonar irreversible con cortocircuito derecha-izquierda (Eisenmenger).

Tarjeta 6 -- FRENTE: Complicaciones por no cerrar oportunamente una PCA.

REVERSO: Insuficiencia cardíaca, endocarditis infecciosa e hipertensión pulmonar (evolución a síndrome de Eisenmenger).

Raquitismo

Tarjeta 1 -- FRENTE: Lactante con rosario raquítrico, craneotabes, genu varo, muñecas ensanchadas y convulsiones por hipocalcemia. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Raquitismo carencial por déficit de vitamina D (la causa más frecuente es la disminución de la síntesis cutánea, seguida de la disminución de la ingesta).

Tarjeta 2 -- FRENTE: Nivel de 25-hidroxivitamina D que define deficiencia de vitamina D según la GPC.

REVERSO: 25-OHD <30 nmol/L (insuficiencia 30-50 nmol/L; suficiencia >50 nmol/L).

Tarjeta 3 -- FRENTE: Hallazgo radiográfico característico del raquitismo en rodilla y muñeca.

REVERSO: Metáfisis de huesos largos ensanchadas con aspecto deshilachado, osteopenia, pérdida de la demarcación metáfisis-placa de crecimiento y pérdida de la zona de calcificación provisional.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Tratamiento del raquitismo carencial: esquema y duración.

REVERSO: Vitamina D (D2 y/o D3) 2000 UI/día por mínimo 3 meses, más calcio oral 500 mg/día. Vigilancia a 1 y 3 meses con calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, PTH, 25-OHD y radiografías.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Dosis de vitamina D para prevención del raquitismo en menores de 1 año.

REVERSO: 400 UI/día desde los primeros días de vida (0-6 meses) y 400-600 UI/día entre 6 y 12 meses, independientemente de la forma de alimentación.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Complicación neuromuscular aguda del raquitismo en lactantes y adolescentes.

REVERSO: Convulsiones y tetania por hipocalcemia; también apnea, estridor laríngeo, hipotonía muscular y miocardiopatía por hipocalcemia.

Reflujo Gastroesofágico en Pediatría

Tarjeta 1 -- FRENTE: Lactante sano de 4 meses con regurgitación sin esfuerzo, buen aumento de peso y examen físico normal. ¿Diagnóstico y conducta?

REVERSO: RGE no complicado (vomitador feliz): no requiere estudios; educación a los padres, comidas pequeñas más frecuentes, espesar alimentos y decúbito supino en menores de 12 meses.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Qué hallazgos definen la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) en pediatría?

REVERSO: Complicaciones: esofagitis, disfagia, odinofagia, hematemesis, anemia, alteraciones respiratorias y falta de ganancia de peso. La poca ganancia de peso NO es típica del RGE y es signo de alarma.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Vómito del lactante con postura cervical distónica (síndrome de Sandifer). ¿Qué sugiere?

REVERSO: Signo de alarma que sugiere enfermedad sistémica o neurológica: obliga a descartar otro diagnóstico antes de atribuirlo a RGE fisiológico.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Tratamiento farmacológico de la esofagitis leve documentada por ERGE, con dosis y duración.

REVERSO: Inhibidor de la bomba de protones (omeprazol 1 mg/kg/día) por 4-8 semanas; en esofagitis moderada o severa erosiva, 3-6 meses. No se recomiendan H2 ni procinéticos.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Indicaciones de funduplicatura de Nissen en ERGE pediátrico.

REVERSO: Falla al tratamiento médico, dependencia prolongada del tratamiento, poco apego, complicaciones que amenacen la vida o daño pulmonar por aspiración.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Índice de reflujo en pHmetría de 24 horas que se considera anormal.

REVERSO: IR >7% (normal <3%, indeterminado 3-7%). La SEG D se indica solo ante sospecha de alteración anatómica; fórmula hidrolizada 2-4 semanas descarta alergia a proteína de leche de vaca.

Retinopatía del Prematuro

Tarjeta 1 -- FRENTE: Criterios de tamizaje de retinopatía del prematuro según la GPC.

REVERSO: Fondoscopia seriada con tropicamida en neonatos con edad gestacional <34 semanas o peso <1,750 g; también pretérmino ≥34 semanas/≥1,750 g que hayan recibido oxígeno suplementario.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Qué se define como enfermedad umbral de la retinopatía del prematuro?

REVERSO: Cinco sectores horarios continuos u ocho acumulados de retinopatía estadio 3 con enfermedad plus en zona I o II (indica tratamiento).

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Qué es la enfermedad plus en la retinopatía del prematuro?

REVERSO: Dilatación y tortuosidad de los vasos del polo posterior en al menos dos de cuatro cuadrantes, que indica actividad angiogénica y puede acompañar cualquier estadio.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Estadio 3 de la retinopatía del prematuro: hallazgo característico.

REVERSO: Crecimiento de tejido vascular (neovasos) hacia el espacio vítreo; el estadio 5 corresponde al desprendimiento retiniano total.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Tratamiento de la retinopatía del prematuro y lugar del bevacizumab.

REVERSO: Crioterapia, láser y cirugía vitreoretiniana; el bevacizumab (anti-VEGF) es de segunda línea. Referencia urgente ante enfermedad preumbral tipo 1.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Meta de saturación de oxígeno recomendada por la GPC para disminuir el riesgo de retinopatía del prematuro.

REVERSO: Mantener SpO2 entre 87-94%; no existe un nivel seguro definido. La ROP y la ceguera cortical son las causas más comunes de ceguera infantil en países desarrollados.

Rinosinusitis Aguda

Tarjeta 1 -- FRENTE: Definición temporal de la rinosinusitis aguda.

REVERSO: Proceso infeccioso e inflamatorio de nariz y senos paranasales que persiste más de 10 días y menos de 3 meses (la forma severa puede clasificarse incluso con 7 días).

Tarjeta 2 -- FRENTE: Agentes etiológicos bacterianos más frecuentes de la rinosinusitis aguda.

REVERSO: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae no tipificable y Moraxella catarrhalis.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Antibiótico de elección en la rinosinusitis aguda, con duración.

REVERSO: Amoxicilina/ácido clavulánico por 10-14 días. Alternativa en alérgicos: claritromicina o eritromicina. Complemento: lavados nasales, oximetazolina y analgésico.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Qué senos paranasales están neumatizados al nacer y cuáles se desarrollan después?

REVERSO: Etmoidales al nacer (maxilares presentes pero neumatizados hacia los 4 años, esfenoidales ~5 años, frontales desde los 7 años hasta la adolescencia).

Tarjeta 5 -- FRENTE: Complicaciones orbitarias e intracraneales de la rinosinusitis aguda.

REVERSO: Celulitis orbitaria, empiema subdural o epidural, absceso cerebral, trombosis del seno dural, tumor de Pott (osteomielitis frontal) y meningitis; son indicación quirúrgica absoluta.

Sepsis Neonatal

Tarjeta 1 -- FRENTE: Agentes más frecuentes de la sepsis neonatal de inicio temprano (<7 días) según la GPC.

REVERSO: Escherichia coli y Klebsiella sp. (los dos más comunes, transmisión vertical); también Streptococcus agalactiae, S. pneumoniae y S. aureus.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Agente más frecuente de la sepsis neonatal de inicio tardío (>7 días).

REVERSO: Staphylococcus epidermidis (hasta 50% de los casos), transmisión nosocomial horizontal; también S. aureus, Pseudomonas, Acinetobacter y Candida.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Esquema antibiótico empírico de elección en sepsis neonatal de inicio temprano.

REVERSO: Ampicilina + aminoglucósido (amikacina o gentamicina); el tratamiento debe iniciarse en la primera hora tras el reconocimiento.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Esquema empírico de elección en sepsis neonatal de inicio tardío asociada a cuidados de la salud (nosocomial).

REVERSO: Cefalosporina de tercera (cefotaxima) o cuarta (cefepime) generación, o carbapenémico (imipenem o meropenem) + vancomicina.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Estándar de oro diagnóstico de la sepsis neonatal y duración del tratamiento con hemocultivo positivo.

REVERSO: Hemocultivo; tratamiento por 7-10 días con hemocultivos positivos, o suspender a las 36 horas si la PCR se normaliza, cultivos negativos y mejoría clínica.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Manejo inicial del choque séptico neonatal.

REVERSO: Cristaloides en bolos de 10 ml/kg, hasta 40-60 ml/kg máximo en la primera hora; choque refractario: vasopresor (epinefrina) o inotrópico (dopamina).

Síndrome Hemolítico Urémico

Tarjeta 1 -- FRENTE: Niño de 4 años con diarrea previa, anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y lesión renal aguda. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Síndrome hemolítico urémico (triada clásica); la causa más común es E. coli productora de toxina Shiga (STEC, ~90% de los casos), en menores de 5 años.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Hallazgos de laboratorio que definen la anemia hemolítica microangiopática del SHU.

REVERSO: Hb <8 g/dL, Coombs negativo y esquistocitos >10% en frotis periférico; también hiperbilirrubinemia indirecta, haptoglobinas bajas y DHL elevada.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Confirmación etiológica del SHU asociado a STEC.

REVERSO: Cultivo en agar MacConkey para E. coli O157:H7 o PCR en heces para genes de toxina Shiga (stx1 y stx2).

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Por qué NO debe administrarse antibiótico en la diarrea por E. coli productora de toxina Shiga?

REVERSO: No reduce la progresión y puede incrementar el riesgo de SHU posterior; el manejo es de sostén.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Metas transfusionales del SHU y criterio de transfusión de plaquetas.

REVERSO: Mantener Hb 8-9 g/dL; plaquetas solo si hay sangrado clínicamente significativo o recuento <10,000/ μ L.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Terapia específica del SHU reservada para pacientes con afectación del SNC.

REVERSO: Plasmaféresis (40-60 ml/kg de plasma fresco congelado) o eculizumab (anticuerpo anti-C5 del complemento); hasta el 20% presenta convulsiones, coma o ceguera cortical.

Síndrome Ictérico Neonatal

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Cuándo se considera patológica la ictericia del recién nacido y qué hallazgo nunca es fisiológico?

REVERSO: Toda ictericia evidente desde el primer día de vida es patológica (la fisiológica inicia a partir del tercer día y se resuelve en ~2 semanas). También lo es la bilirrubina directa >2 mg/dl o >20% del total, que obliga a protocolo de estudio (colestasis, hepatitis, atresia de vías biliares).

Tarjeta 2 -- FRENTE: Neonato con ictericia desde el primer día, madre O Rh+ e hijo A Rh+: ¿estudios iniciales y causa a descartar?

REVERSO: Grupo sanguíneo y Rh madre-hijo más prueba de Coombs directa: descartar enfermedad hemolítica por incompatibilidad ABO/Rh (causa de hiperbilirrubinemia no conjugada).

Tarjeta 3 -- FRENTE: Estándar diagnóstico para conocer el grado de hiperbilirrubinemia neonatal y sus umbrales de severidad.

REVERSO: Bilirrubinas séricas. Severa: 20-24 mg/dl; crítica o extrema: 25-30 mg/dl (en $\geq$ 35 semanas). La bilirrubinometría transcutánea es aceptable como tamizaje.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Tratamiento de elección de la hiperbilirrubinemia no conjugada cuando fracasa la fototerapia o existe encefalopatía.

REVERSO: Exanguinotransfusión (intercambio al doble del volumen circulante). Fototerapia con luz azul de 460-490 nm; contraindicada con antecedente familiar de porfiria.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Complicación neurológica aguda y crónica de la hiperbilirrubinemia indirecta (kernicterus).

REVERSO: Acumulación de bilirrubina en globo pálido y núcleos basales (depósitos en RM T2). Fase aguda: succión precaria, opistótonos; crónica: coreoatetosis, pérdida auditiva sensorineural y desviación superior de la mirada.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Acumulación de ictericia en palmas y plantas en la clasificación de Kramer. ¿Grado y nivel aproximado?

REVERSO: Grado 5 de Kramer, correspondiente a >14.7 mg/dl de bilirrubina (grado 1: cabeza y cuello ~5.8 mg/dl).

Síndrome de Aspiración de Meconio (SAM)

Tarjeta 1 -- FRENTE: Recién nacido postérmino con líquido amniótico meconial, taquipnea, tórax abombado y estertores en las primeras horas. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Síndrome de aspiración de meconio (SAM). Ocurre en el 5% de los nacimientos con líquido meconial (presente en 10-15%); 30% requiere ventilación mecánica y mortalidad 3-5%.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Hallazgo radiográfico característico del síndrome de aspiración de meconio.

REVERSO: Sobredistensión pulmonar con patrón difuso en parches: áreas opacas alternadas con zonas de atelectasia y atrapamiento aéreo, diafragma aplanado; es común la fuga de aire (neumotórax, neumomediastino).

Tarjeta 3 -- FRENTE: Gradiente pre- y posductal de saturación de oxígeno mayor a 5-10% en SAM. ¿Qué sugiere?

REVERSO: Cortocircuito de derecha a izquierda por hipertensión pulmonar persistente; debe corroborarse con ecocardiograma.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Clasificación de severidad del SAM según Cleary y Wiswell.

REVERSO: Leve: O₂ <40% en primeras 48 horas; moderado: O₂ >40% por más de 48 horas; grave: intubación y ventilación asistida >48 horas, generalmente con hipertensión pulmonar persistente.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Manejo del SAM muy grave además del soporte ventilatorio.

REVERSO: Óxido nítrico inhalado o factor surfactante, que reducen presiones de vía aérea y la necesidad de ECMO. Meta: pO₂ 55-99 mmHg (SpO₂ 90-94%).

Tarjeta 6 -- FRENTE: Complicaciones agudas del síndrome de aspiración de meconio.

REVERSO: Neumotórax, neumomediastino, neumonía bacteriana e hipertensión pulmonar persistente; además es factor de riesgo de encefalopatía hipóxica-isquémica (OR 90).

Síndrome de Dificultad Respiratoria Neonatal

Tarjeta 1 -- FRENTE: Prematuro de 29 semanas con taquipnea, quejido espiratorio, tiraje y cianosis progresiva desde los primeros minutos. ¿Diagnóstico y fisiopatología?

REVERSO: Síndrome de dificultad respiratoria neonatal tipo 1 (enfermedad de la membrana hialina), por deficiencia de factor surfactante de neumocitos tipo II con atelectasia; frecuencia 50-60% en <30 SEG.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Hallazgo radiográfico característico del síndrome de dificultad respiratoria neonatal.

REVERSO: Infiltrado reticulogranular fino bilateral con broncograma aéreo y volumen pulmonar disminuido; en estadio IV, opacidad total en vidrio esmerilado sin distinguir la silueta cardíaca.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Tratamiento óptimo actual del síndrome de dificultad respiratoria neonatal.

REVERSO: CPAP nasal desde el nacimiento (idealmente en sala de partos, ≥ 6 cm H₂O) más surfactante temprano (primera hora, sin esperar radiografía).

Tarjeta 4 -- FRENTE: Dosis de surfactante de primera elección en el síndrome de dificultad respiratoria neonatal.

REVERSO: Poractant alfa 2.5 ml/kg (200 mg/kg/dosis); segunda elección: poractant alfa 1.25 ml/kg o beractant 4 ml/kg. Los surfactantes naturales (porcino) superan a los sintéticos.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Cómo se previene el síndrome de dificultad respiratoria neonatal en el parto pretérmino?

REVERSO: Corticoides prenatales (betametasona o dexametasona) entre las 24 y 34 semanas; más efectivos si se administran al menos 24 horas antes del nacimiento.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Criterios gasométricos y de CPAP que indican intubación en el prematuro con SDR.

REVERSO: pO₂ <50 mmHg en aire ambiental, SpO₂ baja pese a FiO₂ >50%, presión >8 cm H₂O, incapacidad de mantener PaCO₂ <60 mmHg, apneas o inestabilidad cardíaca; meta de SpO₂ 90-94%.

Síndrome de Eisenmenger

Tarjeta 1 -- FRENTE: Paciente con cardiopatía izquierda-derecha no corregida que desarrolla cianosis por inversión del cortocircuito. ¿Diagnóstico y cardiopatías predisponentes?

REVERSO: Síndrome de Eisenmenger: complicación evolutiva de cardiopatías acianógenas no corregidas (CIA, CIV, PCA) con enfermedad vascular pulmonar e inversión del cortocircuito.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Tratamiento definitivo del síndrome de Eisenmenger.

REVERSO: Trasplante cardiopulmonar (único tratamiento definitivo); indicaciones: supervivencia a 1 año <50%, síncope, falla cardíaca refractaria o clase funcional III-IV NYHA.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Fármacos vasodilatadores pulmonares utilizados en el síndrome de Eisenmenger.

REVERSO: Antagonistas de calcio (nifedipino), prostanoides (epoprostenol, iloprost), antagonistas de endotelina (bosentán) e inhibidores de fosfodiesterasa 5 (sildenafil, tadalafil); meta: vasodilatación pulmonar.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Método anticonceptivo contraindicado en mujeres con síndrome de Eisenmenger.

REVERSO: Anticonceptivos hormonales combinados con estrógenos (orales, parche, anillo vaginal) por riesgo protrombótico (categoría 4 de los CME-OMS). Preferir progestágeno solo, DIU de cobre o esterilización.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Hallazgos hematológicos característicos del síndrome de Eisenmenger y sus riesgos.

REVERSO: Policitemia secundaria con hiperviscosidad, deficiencia de hierro y diátesis hemorrágica/trombótica: hemoptisis, accidente cerebrovascular y tromboembolia pulmonar.

Síndrome de Klinefelter

Tarjeta 1 -- FRENTE: Varón joven con esterilidad por azoospermia, ginecomastia y talla alta por predominio de piernas. ¿Diagnóstico más probable?

REVERSO: Síndrome de Klinefelter (incidencia 1/500 varones): hipogonadismo por cromosoma sexual extra; cariotipo más frecuente 47,XXY.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Hallazgo de laboratorio característico en el análisis de leucocitos del síndrome de Klinefelter y perfil hormonal.

REVERSO: Corpúsculo de Barr positivo (inactivación del X extra) con FSH elevada y testosterona reducida.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuál es el riesgo oncológico aumentado en el síndrome de Klinefelter?

REVERSO: Mayor riesgo de cáncer mamario (punto de examen: ginecomastia más masa mamaria en varón).

Tarjeta 4 -- FRENTE: Estudio que confirma el síndrome de Klinefelter.

REVERSO: Cariotipo: 47,XXY (variantes mosaicas 48,XXXY y 49,XXXXY). Diferencial: el síndrome de Turner es la contraparte femenina por monosomía X.

Síndrome de Turner

Tarjeta 1 -- FRENTE: Recién nacida con higroma quístico en el cuello. ¿Diagnóstico más probable?

REVERSO: Síndrome de Turner (monosomía X; 57% cariotipo 45,XO, incidencia 1/2000 nacidas vivas); el higroma evoluciona a cuello alado persistente.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Cardiopatías asociadas al síndrome de Turner (punto de examen).

REVERSO: Coartación aórtica y válvula aórtica bicúspide; también riñón en herradura y teletelia (pezones separados).

Tarjeta 3 -- FRENTE: Mujer joven con amenorrea primaria, talla baja y estriación ovárica. ¿Diagnóstico y mecanismo?

REVERSO: Síndrome de Turner: estriación ovárica con pérdida prematura de oocitos (hipogonadismo hipergonadotrópico). La talla baja es el rasgo más constante.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Qué porcentaje de conceptos con cariotipo 45,XO sobrevive la gestación?

REVERSO: Solo una minoría: la gran mayoría de los 45,XO no sobrevive la gestación (aborto); 29% son mosaicismos y 14% anomalías estructurales del X.

Taquipnea Transitoria del Recién Nacido

Tarjeta 1 -- FRENTE: RN de término por cesárea electiva sin trabajo de parto, con taquipnea >60/min desde las primeras horas y buena saturación con oxígeno bajo. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Taquipnea transitoria del recién nacido (TTRN o pulmón húmedo, SDR tipo 2): retención de líquido pulmonar por falta de reabsorción; resuelve en 24-72 horas.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Hallazgo radiográfico característico de la taquipnea transitoria del recién nacido.

REVERSO: Atrapamiento aéreo con congestión parahiliar simétrica, cisuritis, cardiomegalia aparente y diafragmas aplanados. Diferencial: SDR tipo 1 cursa con infiltrado reticulogranular.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Factores de riesgo maternos de la taquipnea transitoria del recién nacido.

REVERSO: Asma, diabetes mellitus, tabaquismo, ruptura prematura de membranas >24 horas y nacimiento sin trabajo de parto (cesárea electiva).

Tarjeta 4 -- FRENTE: Manejo de primera línea de la taquipnea transitoria del recién nacido.

REVERSO: Oxígeno por casco cefálico (rara vez FiO₂ >40%) con meta SpO₂ 88-95%; CPAP si no se mantienen metas o aumenta Silverman-Andersen. No se recomiendan furosemida, salbutamol ni epinefrina racémica.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Complicaciones poco frecuentes de la taquipnea transitoria del recién nacido.

REVERSO: Hipertensión pulmonar persistente y neumotórax; se autolimita entre las primeras 24-72 horas de vida.

Tetralogía de Fallot

Tarjeta 1 -- FRENTE: Cuatro componentes anatómicos de la tetralogía de Fallot.

REVERSO: CIV subaórtica, obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho (estenosis pulmonar), hipertrofia ventricular derecha y cabalgamiento aórtico.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Cardiopatía congénita cianótica más frecuente en mayores de un año.

REVERSO: Tetralogía de Fallot (incidencia 0.1/1000 nacidos vivos); en menores de un año es la transposición de grandes vasos.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Silueta cardíaca en forma de bota con soplo sistólico eyectivo áspero 3-5/6 en borde esternal izquierdo. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Tetralogía de Fallot: corazón en bota de tamaño normal con ECG de eje derecho e hipertrofia ventricular derecha. El soplo proviene de la estenosis pulmonar, no de la CIV.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Lactante con tetralogía de Fallot en crisis de hipoxia: manejo inicial.

REVERSO: Posición genupectoral (acucillamiento) sostenida, oxígeno y morfina; puede usarse ketamina, dexmedetomidina o esmolol. Prevención de nuevas crisis: propranolol.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Cirugía correctiva de la tetralogía de Fallot.

REVERSO: Cierre de la CIV con parche, ampliación del tracto de salida del ventrículo derecho con resección muscular y valvuloplastia pulmonar; manejo paliativo previo: fístula sistémico-pulmonar.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Factores que precipitan las crisis de hipoxia en la tetralogía de Fallot.

REVERSO: Dolor, ansiedad, llanto sostenido, ejercicio, estreñimiento, anemia ferropriva e hipovolemia; complicación: acidosis metabólica por disminución severa del flujo pulmonar.

Transposición de Grandes Vasos (TGV)

Tarjeta 1 -- FRENTE: Cardiopatía congénita cianótica más frecuente en menores de un año.

REVERSO: Transposición de grandes vasos (aorta del ventrículo derecho y arteria pulmonar del izquierdo, discordancia ventrículo-arterial); incompatible con la vida sin cortocircuito bidireccional.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Recién nacido con cianosis que no mejora con oxígeno. ¿Sospecha diagnóstica y confirmación?

REVERSO: Transposición de grandes vasos; se confirma con ecocardiograma. Diferencial con la tetralogía de Fallot: en la TGV la cianosis es temprana e intensa sin soplo característico.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Manejo inmediato del recién nacido con transposición de grandes vasos confirmada.

REVERSO: Prostaglandinas (mantener permeable el conducto) y septostomía auricular con balón en hemodinamia.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Cirugía de elección de la transposición de grandes vasos.

REVERSO: Switch arterial (cirugía de Jatene), con transposición de las arterias a su ventrículo correspondiente.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Factores de riesgo maternos asociados a la transposición de grandes vasos.

REVERSO: Madres diabéticas, desnutridas o con consumo de alcohol durante el embarazo.

Tumor de Wilms (Nefroblastoma)

Tarjeta 1 -- FRENTE: Niña de 3 años con masa abdominal palpable, hemihipertrofia e hipertensión. ¿Diagnóstico más probable?

REVERSO: Tumor de Wilms (nefroblastoma), cáncer renal más frecuente en pediatría; incidencia máxima a los 2-4 años (80% antes de los 5 años).

Tarjeta 2 -- FRENTE: Estudio de diagnóstico de certeza del tumor de Wilms según la GPC.

REVERSO: Tomografía computarizada abdominal con doble contraste (diagnóstico de certeza en 82% de los casos); el tumor se origina del parénquima renal.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Asociaciones sindrómicas del gen WT1 (11p13) en el tumor de Wilms.

REVERSO: Asociación WAGR (tumor de Wilms, aniridia, malformaciones genitourinarias, discapacidad intelectual) y síndromes Denys-Drash y Frasier; WT2 (11p15): Beckwith-Wiedemann y hemihipertrofia.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Qué define histología desfavorable en el tumor de Wilms y su supervivencia?

REVERSO: Anaplasia difusa; supervivencia global a 4 años de 50% (vs 90% en histología favorable).

Tarjeta 5 -- FRENTE: Tratamiento quirúrgico de elección del tumor de Wilms en estadio I y II.

REVERSO: Nefrectomía total (la quimioterapia neoadyuvante se reserva para enfermedad bilateral, trombo tumoral en vena cava suprahepática o tumor irreseccable).

Tarjeta 6 -- FRENTE: Signo que distingue al tumor de Wilms del neuroblastoma como masa renal.

REVERSO: Tumor renal sólido sin calcificaciones (el neuroblastoma suele calcificar y cruza la línea media); presenta hematuria, hipertensión y trombo en vena renal.

Tumores Malignos en Pediatría - Generalidades

Tarjeta 1 -- FRENTE: Distribución aproximada de las neoplasias pediátricas entre tumores sólidos y hematológicos.

REVERSO: 60% tumores sólidos y 40% leucemia o linfoma; incidencia anual estimada de 12-14 casos por 100,000 menores de 15 años.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Tumor sólido más frecuente en pediatría y su porcentaje aproximado.

REVERSO: Tumores del sistema nervioso central (35%); siguen neuroblastoma (15%), tumores óseos (8%), sarcomas de tejidos blandos (7%), tumor de Wilms (6%) y retinoblastoma (5%).

Tarjeta 3 -- FRENTE: Características biológicas que distinguen los tumores malignos infantiles de los del adulto.

REVERSO: Periodos cortos de latencia, crecimiento rápido con invasión agresiva y mejor respuesta a quimioterapia; 10-15% se asocian a trastornos genéticos o familiares.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Qué porcentaje de cánceres pediátricos se presenta en contexto de asociación familiar o trastorno genético?

REVERSO: Alrededor del 10-15%; el resto son esporádicos.